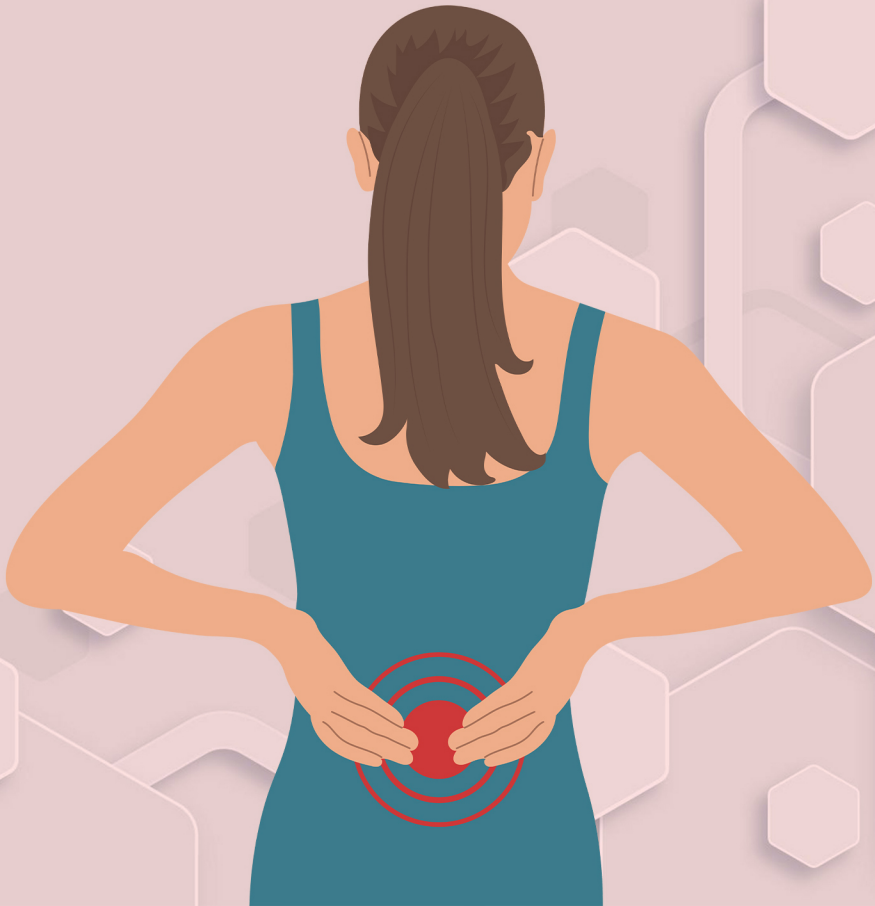




Nuansa
Fajar
Cemerlang

PRENATAL YOGA DAN HIPNOTERAPI SEBAGAI METODE TERINTEGRASI UNTUK MANAJEMEN NYERI PUNGGUNG PADA KEHAMILAN

Sestu Retno Dwi Andayani • Rodiyah
Dewi Ratih Purnomo



PRENATAL YOGA DAN HIPNOTERAPI SEBAGAI METODE TERINTEGRASI UNTUK MANAJEMEN NYERI PUNGGUNG PADA KEHAMILAN

Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

Rodiyah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dewi Ratih Purnomo, S.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Prenatal Yoga dan Hipnoterapi sebagai Metode Terintegrasi untuk Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan

Penulis: Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.
Rodiyah, S.Kep,Ns,M.Kes.
Dewi Ratih Purnomo, S.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-19-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Prenatal yoga dan hipnoterapi sebagai metode terintegrasi untuk manajemen nyeri punggung pada kehamilan / penulis, Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes., Rodiyah, S.Kep, Ns, M.Kes., Dewi Ratih Purnomo, S.Kep.

EDISI

Cetakan pertama, Januari 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.

DESKRIPSI FISIK

vi, 82 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-19-1

SUBJEK

Kehamilan -- Nyeri

KLASIFIKASI

618.244 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1181444>

PRAKATA

Kami panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga penulis dapat menyusun Buku yang berjudul **“Prenatal Yoga dan Hipnoterapi sebagai Metode Terintegrasi untuk Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan”**. Buku ini disusun sebagai bentuk inovasi dalam menangani nyeri punggung yang dialami oleh hampir semua ibu hamil, berdasarkan beberapa teori yang mendasari dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 di RSUD Jombang. Buku ini berisi konsep-konsep teoritis tentang Kehamilan, senam Yoga, Hipnoterapi dan hasil penelitian, serta. penanganan nyeri punggung yang dialami oleh ibu hamil.

Sebagian besar ibu hamil mengalami nyeri punggung saat hamil, yang biasanya muncul pada trimester kedua kehamilan. Nyeri punggung pada ibu hamil cenderung meningkat seiring usia kehamilan. Karena nyeri punggung saat hamil dapat menyebabkan nyeri jangka panjang, meningkatkan kemungkinan nyeri setelah melahirkan, dan menjadi sulit untuk disembuhkan, keluhan saat hamil harus segera ditangani. Nyeri punggung ini bisa diminimalis sejak usia kehamilan memasuki trimester II dengan senam Prenatal yoga dan hipnoterapi.

Prenatal yoga berfokus pada dasar-dasar postur dan teknik pernapasan dalam. Latihan pernapasan memberikan kesempatan ibu hamil untuk mengendalikan emosi dan pikiran serta lebih fokus pada kondisi dan situasi saat ini. Latihan pernapasan bagian dari pengendalian diri, di mana orang berusaha mengatur dirinya sendiri baik secara emosional maupun perilaku. Saat melakukan senam yoga, ibu hamil juga bisa mendapatkan dukungan sosial dengan sesama ibu hamil beserta instruktur yoga.

Hipnoterapi dapat menurunkan tingkat nyeri punggung pada ibu hamil karena hipnoterapi berpengaruh pada sistem limbik dan saraf otonom, menciptakan suasana yang tenang, aman, dan menyenangkan. Hipnoterapi mempengaruhi pusat rasa ganjaran dan melepaskan substrat kimia gamma amino butyric acid (GABA), enkephalin, dan endorphin, yang menghilangkan neurotransmitter nyeri. Relaksasi hipnoterapi akan menuntun agar ibu hamil tetap dalam kondisi rileks dan tidak memikirkan dan merasakan nyeri punggung yang ditimbulkan dari peningkatan usia kehamilan dan peningkatan berat janin dalam kandungan

Buku ini diharapkan menjadi sebuah informasi baik masyarakat umum, mahasiswa keperawatan maupun mahasiswa bidang kesehatan dalam teori-teori perkembangan keperawatan yang telah diperbarui berdasarkan dan inovasi dari hasil penelitian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada STIKES Pemkab Jombang yang telah mengizinkan kami melakukan penelitian. Terima kasih kepada RSUD Jombang yang telah berkenan menjadi tempat penelitian "Prenatal Yoga dan Hipnoterapi sebagai Metode Terintegrasi untuk manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan". Terima kasih kepada Bidan Desa Bandung dan Mombykids yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini".

Kami sadar bahwa penyusunan buku ini masih perlu untuk terus disempunakan sesuai dengan kemajuan ilmu kesehatan. Segala saran untuk perbaikan buku ini, akan sangat kami hargai dan harapkan.

Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

BAB 2 NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL 13

- A. Definisi Nyeri Punggung 13
- B. Etiologi..... 21
- C. Proses Terjadinya Nyeri Punggung Bawah
Kehamilan Trimester III 31
- D. Faktor - faktor yang mempengaruhi nyeri
punggung bawah trimester III pada kehamilan 34
- E. Akibat Nyeri Punggung Bagian Bawah..... 35
- F. Pengukuran Skala Nyeri 36
- G. Teknik manajemen untuk nyeri punggung pada
kehamilan 37

**BAB 3 KOMBINASI PRENATAL YOGA DAN
HIPNOTERAPI 41**

- A. Prenatal Yoga 41

B. Hipnoterapi	44
C. Prenatal Yoga dan Hipnoterapi sebagai Metode Terintegrasi untuk Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan.....	46

BAB 4 PERAN PRENATAL YOGA DAN HIPNOTERAPI 57

A. Hasil Integrasi.....	57
B. Pendekatan Holistik dalam Mengatasi Nyeri Punggung pada Ibu Hamil	59

BAB 5 PENUTUP..... 64

A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Praktis.....	66
C. Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA..... 72

GLOSARIUM 75

PROFIL PENULIS 79

BAB 1

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan proses biologis yang dimulai sejak terjadinya konsepsi hingga bayi dilahirkan, di mana secara umum periode ini berlangsung selama kurang lebih 280 hari atau sekitar 40 minggu, yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT). Selama masa kehamilan, perkembangan janin dan perubahan tubuh ibu dibagi ke dalam tiga trimester berdasarkan usia kehamilan. Trimester pertama mencakup minggu ke-1 hingga minggu ke-13, di mana proses organogenesis atau pembentukan organ vital janin berlangsung. Trimester kedua mencakup minggu ke-14 hingga minggu ke-27, yang sering dianggap sebagai periode stabil karena sebagian besar ibu mulai beradaptasi dengan perubahan tubuhnya. Sementara itu, trimester ketiga dimulai dari minggu ke-28 hingga minggu ke-41 dan menjadi periode yang cukup menantang bagi sebagian besar ibu hamil karena adanya peningkatan ketidaknyamanan fisik, ketegangan mental, serta kecemasan menjelang persalinan. Beberapa keluhan umum yang sering muncul pada fase ini antara lain nyeri punggung bagian bawah, gangguan pernapasan akibat desakan uterus pada diafragma, kesulitan tidur karena perubahan hormon dan ukuran perut yang membesar, sering buang air kecil karena tekanan pada kandung kemih, kontraksi perut atau *Braxton Hicks*, pembengkakan pergelangan kaki akibat retensi cairan, kram otot kaki, serta perasaan cemas yang meningkat seiring mendekatnya waktu persalinan (Dheska, Sri. 2018).

Seiring bertambahnya usia kehamilan, ukuran uterus akan membesar secara signifikan sehingga memengaruhi pusat gravitasi tubuh ibu. Pergeseran pusat gravitasi ke depan membuat ibu hamil harus beradaptasi dengan postur tubuhnya, terutama ketika berdiri atau bergerak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekuatan otot, peningkatan berat badan, relaksasi sendi akibat hormon kehamilan, tingkat kelelahan fisik, dan postur tubuh sebelum kehamilan. Perubahan ini sering kali menyebabkan terjadinya hiperlordosis, yaitu lengkungan berlebihan pada tulang belakang bagian bawah untuk menyeimbangkan tubuh. Tidak jarang, kondisi ini akan disertai dengan kompensasi berupa kifosis atau lengkungan pada tulang belakang bagian torakal. Meskipun ada sebagian ibu hamil yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan postural ini, tidak sedikit yang mengalami nyeri punggung akibat ketegangan otot yang terus-menerus serta tekanan pada struktur tulang belakang (Lilis, 2019).

Selain perubahan pada postur tubuh, peningkatan berat badan selama masa kehamilan juga menjadi faktor signifikan yang turut berkontribusi terhadap ketidaknyamanan fisik. Peningkatan berat badan yang cukup drastis, khususnya pada trimester ketiga, akan memberikan beban tambahan pada area lumbar atau punggung bagian bawah, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih besar pada otot-otot di sekitarnya. Tekanan berlebih ini kemudian dapat memicu terjadinya nyeri punggung yang berkelanjutan, gangguan tidur, serta masalah psikologis yang, jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada kualitas hidup ibu hamil (Fatmarizka et al., 2021). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa nyeri punggung bawah merupakan salah satu ketidaknyamanan paling sering dialami ibu hamil, terutama pada trimester ketiga kehamilan. Di Indonesia sendiri, penelitian yang melibatkan 180 ibu hamil

menunjukkan bahwa sekitar 47% di antaranya mengalami keluhan nyeri punggung selama kehamilan (Munir et al., 2022).

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2021, diketahui bahwa angka kejadian ibu hamil dengan komplikasi yang memerlukan penanganan mencapai 102,6%, atau sebanyak 4.108 ibu hamil termasuk dalam kategori berisiko tinggi. RSUD Kabupaten Jombang, yang berstatus sebagai rumah sakit rujukan regional tipe B sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, memainkan peran yang sangat penting dalam menangani berbagai kasus komplikasi kehamilan, termasuk nyeri punggung yang kerap terjadi pada ibu hamil trimester ketiga (Humas RSUD Jombang, 2023).

Nyeri punggung yang dialami ibu hamil cenderung akan semakin memburuk seiring dengan bertambahnya usia kehamilan dan besarnya ukuran perut. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi atau penanganan yang tepat, nyeri tersebut berpotensi berkembang menjadi nyeri kronis yang dapat bertahan bahkan setelah proses persalinan selesai. Nyeri kronis ini membutuhkan waktu pemulihan yang jauh lebih lama dan dapat mengganggu aktivitas ibu pasca melahirkan (Fazriani & Marwasariaty, 2024). Adapun penyebab nyeri punggung bawah pada ibu hamil antara lain meliputi ketegangan otot, kelelahan fisik, postur tubuh yang tidak tepat saat mengangkat barang, peningkatan kadar hormon relaksin yang melonggarkan sendi, serta posisi tulang belakang yang mengalami hiperlordosis. Upaya pencegahan nyeri punggung pada ibu hamil mencakup beberapa langkah, seperti menghindari postur tubuh yang salah, tidak menggunakan sepatu berhak tinggi, memilih kasur yang lebih keras, menjaga postur tubuh agar tetap ergonomis, serta berolahraga secara teratur. Beberapa aktivitas yang terbukti efektif untuk meredakan nyeri punggung adalah senam hamil, prenatal yoga,

menjaga berat badan ideal sesuai usia kehamilan, serta melakukan pijat punggung atau *massage* dengan teknik yang tepat (Tyastuti, 2016).

Berat badan yang berlebihan selama kehamilan dapat memperberat kinerja otot dan persendian, sehingga menimbulkan tekanan yang tidak seimbang pada tubuh. Selain itu, pembesaran uterus yang menyebabkan pergeseran pusat gravitasi tubuh juga berkontribusi pada melemahnya otot perut dan meningkatnya beban pada tulang belakang. Akibatnya, tulang belakang cenderung tertarik ke belakang, memicu hiperlordosis yang kemudian menyebabkan ketegangan otot punggung dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup signifikan (Robson & Jason, 2013).

Penanganan nyeri punggung pada ibu hamil dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Namun, penggunaan obat-obatan seperti Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs (NSAID), terutama pada trimester ketiga kehamilan, tidak dianjurkan karena dapat membahayakan kondisi janin. Oleh karena itu, metode non-farmakologis lebih direkomendasikan sebagai alternatif yang aman dan efektif. Beberapa metode non-farmakologis yang dapat dilakukan meliputi manipulasi jaringan lunak, latihan untuk stabilisasi postur tubuh, serta stimulasi saraf listrik transkutan (TENS) yang harus dilakukan oleh tenaga profesional (Manyozo et al., 2019). Salah satu metode non-farmakologis yang sudah banyak diteliti dan terbukti efektif dalam meredakan nyeri punggung adalah prenatal yoga (Kinser et al., 2017; Rong et al., 2021; Wulandari et al., 2020).

Yoga adalah sebuah bentuk latihan yang melibatkan aspek fisik, mental, dan emosional, yang bermanfaat untuk menenangkan pikiran serta melemaskan persendian, terutama bagi ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga. Gerakan yoga

untuk ibu hamil dirancang dengan tempo yang lebih lambat dan disesuaikan dengan kondisi tubuh mereka selama kehamilan (Fazriani & Marwasariaty, 2024). Prenatal yoga merupakan metode olahraga yang mencakup latihan fisik, pernapasan, dan relaksasi mental, yang efektif membantu ibu hamil merasa lebih rileks dan tenang, khususnya di trimester kedua dan ketiga (Wulandari et al., 2020).

Yoga merupakan kombinasi latihan fisik, mental, dan pernapasan yang membantu menenangkan pikiran serta merelaksasi persendian tubuh. Pada ibu hamil, gerakan yoga dirancang dengan lebih lambat, lembut, serta disesuaikan dengan kondisi tubuh mereka, khususnya di trimester kedua dan ketiga (Fazriani & Marwasariaty, 2024). Prenatal yoga merupakan bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh, melatih pernapasan, serta membantu relaksasi mental. Aktivitas ini tidak hanya membantu meredakan nyeri punggung dan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional ibu dengan membantu membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan janin (Gustina & Nurbaiti, 2020).

Olahraga teratur seperti prenatal yoga sangat dianjurkan selama kehamilan, dengan catatan bahwa intensitas dan durasi latihan harus disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Prenatal yoga idealnya dimulai sejak minggu ke-20 kehamilan dan dilakukan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat yang optimal (Rosmadewi & Rudiyaniti, 2018). Latihan yang teratur dapat membantu meredakan nyeri punggung, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kesiapan mental dan fisik ibu menjelang persalinan. Dengan demikian, prenatal yoga tidak hanya berperan dalam meredakan nyeri, tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan kesejahteraan mental ibu

selama masa kehamilan. Gerakan yoga kehamilan dilakukan dengan waktu lebih lambat dan cocok untuk gerakan ibu hamil yang terbatas (Sulistiyaningsih & Rofika, 2020). Prenatal yoga memiliki lima dasar yaitu olahraga fisik, pernafasan (pranaya), postur tubuh (mudra), meditasi dan relaksasi mendalam (Aprilia, 2015).

Terdapat 3 aturan dalam yoga prenatal, yaitu jangan menekan perut, jangan meregangkan area sekitar perut, dan jangan memutar area perut. Selain itu, saat melakukan latihan prenatal yoga, dianjurkan jangan melakukan gerakan peregangan berlebihan karena tubuh ibu hamil akan memproduksi hormon relaxatin untuk merelaksasi persendian yang bermanfaat untuk mempersiapkan jalan lahir bayi, sehingga akan berdampak pada tubuh ibu hamil. Tubuh menjadi lebih lentur, sehingga ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perenggangan terlalu banyak untuk menghindari cedera (Adnyani, 2021).

Saat melakukan latihan prenatal yoga, ibu hamil dilarang melakukan tindakan yang berlebihan, karena saat hamil jumlah darah dan air dalam tubuh mengalami kenaikan yang dapat meningkatkan beban jantung. Jika ibu hamil melakukan tindakan berlebihan, kerja jantung akan semakin meningkat dan seringkali menyebabkan kesulitan bernapas atau sesak napas (Adnyani, 2021),.

Prenatal yoga berfokus pada dasar-dasar postur dan teknik pernapasan dalam. Latihan pernapasan bisa menyebabkan ibu hamil mampu mengendalikan emosi dan pikiran serta lebih fokus pada kondisi dan situasi kehamilannya. Latihan pernapasan bagian dari pengendalian diri, di mana ibu hamil berusaha mengatur dirinya sendiri baik secara emosional maupun perilaku. Saat melakukan senam yoga, ibu hamil juga bisa mendapatkan suport sosial dengan sesama ibu hamil

beserta instruktur yoga. Manfaat prenatal yoga diantaranya adalah membantu meredakan nyeri punggung, membentuk postur tubuh yang baik saat hamil, relaksasi dan mengatasi stres, dapat mengatur sistem pernafasan, meningkatkan sirkulasi darah (Wulansari, 2021).

Menurut Setyoputri & Ismiyati (2023), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil saat melaksanakan yoga, yaitu:

1. Jangan melakukan gerakan yang menekan perut, seperti postur kobra (Bhujaungasana), postur belalang (Salabhasana) dan postur busur (Dhanurasana);
2. Saat melakukan gerakan memutar punggung, dilakukan secara pelan, cukup putar bagian belikat hingga ke leher, hindari memutar daerah panggul karena dapat membahayakan uterus dan janin;
3. Disarankan untuk tidak menggerakkan tubuh terbalik karena dapat meningkatkan emboli pada aliran darah;
4. Jangan tidur telentang dalam kurun waktu yang lama karena dapat menyumbat pembuluh darah balik (vena cava inferior) yang mengalirkan darah kotor dari tubuh ke jantung. Gerakan berbaring dapat dimodifikasi dengan berbaring miring kearah kiri;
5. Jangan bangun secara tiba-tiba dari posisi duduk, berbaring dan jongkok karena dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan;
6. Hindari melakukan gerakan kepala lebih rendah dari pada jantung;
7. Jika mengalami varises, disarankan menghindari gerakan jongkok;
8. Memakai matras yoga untuk menghindari tergelincir saat melakukan yoga;

9. Jangan makan tepat sebelum melaksanakan yoga untuk mengantisipasi perut terasa penuh;
10. Disarankan untuk menggunakan pakaian yang longgar agar nyaman saat melakukan yoga;

Salah satu strategi penanganan nyeri dapat dilakukan hipnoterapi. Hipnoterapi adalah metode pengobatan yang dilakukan ibu hamil dalam keadaan rileks. Cara kerja hipnoterapi terhadap penurunan nyeri, hipnoterapi menghalangi hantaran rasa sakit untuk mencapai bagian otak yang mengalami rasa sakit sesuai dengan perubahan aktivitas otak, yang terkait dengan penekanan rasa sakit persepsi rasa sakit dan meningkatkan aktifitas di area lain. Struktur kortikal cenderung tidak menerima sinyal nyeri ketika ada peningkatan aktifitas dopaminergik. Hipnoterapi adalah terapi non farmakologi yang dengan sangat mudah, cepat, efektif dan efisien menjangkau pikiran bawah sadar, mendidik kembali dan menyembuhkan pikiran yang sakit serta memberikan solusi yang lebih cepat dan permanen. Hipnoterapi dapat membantu mengatasi berbagai kondisi medis dan faktor psikologis yang memengaruhi gejala fisik (Ramadhan et al., 2024).

Hipnoterapi merupakan salah satu jenis psikoterapi dalam psikiatri. Model pengobatan ini dapat dikombinasikan dengan jenis pengobatan lainnya seperti prenatal yoga untuk dapat meningkatkan fungsinya sebagai penetralisir nyeri punggung pada ibu hamil (Pramesti et al., 2023). Metode hipnoterapi memberikan rasa nyaman dengan memberikan informasi tentang cara mengendalikan nyeri. Hipnoterapi merupakan satu bentuk pengobatan tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi kesulitan yang timbul selama kehamilan. Dengan mengajarkan ibu hamil bagaimana melakukan self-hipnosis di rumah mereka sendiri, hipnoterapi dapat digunakan sebagai intervensi alternatif di kelas ibu hamil. Hipnosis menurunkan

kesadaran sensorik sambil meningkatkan konsentrasi dan sugestibilitas (Halim & Khayati, 2020).

Prenatal yoga yang dikombinasikan dengan hipnoterapi dapat membantu ibu hamil untuk merelaksasikan punggung baik dari sisi fisiologis maupun psikologis. Prenatal yoga yang dikombinasikan dengan hipnoterapi yang dilakukan secara teratur 2x seminggu selama 4 minggu terbukti secara signifikan dapat meminimalisir nyeri punggung pada ibu hamil.

Terdapat dua jenis terapi yang dapat digunakan dalam tindakan keperawatan untuk mengurangi atau menghentikan nyeri, diantaranya terapi farmakologis dengan memberikan analgesik yang berfungsi untuk menghentikan transmisi stimulus sehingga persepsi berubah, mengurangi reaksi kortikal terhadap nyeri. Sedangkan terapi non farmakologis mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri, seperti ketidakpercayaan, kesalahpahaman. Hipnoterapi adalah cara non-farmakologi lain untuk mengatasi nyeri. Perawat membantu dalam penanganan non-farmakologi ini. Hipnoterapi adalah bidang ilmu psikologis yang mempelajari bagaimana sugesti dapat membantu orang dengan masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Selama sesi hipnoterapi, kita akan diajarkan untuk memasuki keadaan trance atau relaksasi pikiran, sehingga pikiran kita lebih siap untuk menerima saran yang diberikan oleh terapis (Aprilyadi et al., 2020).

Hipnoterapi adalah upaya untuk menanamkan maksud dan sugesti positif ke dalam alam bawah sadar selama kehamilan dan persiapan persalinan. Ini dapat membantu mengurangi nyeri dan stres, membuat ibu lebih tenang saat persalinan (Nurmitasari, 2022). Salah satu manfaat hipnoterapi pada ibu hamil adalah memberikan saran berupa afirmasi atau kalimat perintah agar subjek hipnosis dapat segera masuk ke alam pikiran bawah sadar, yang membuat ibu rileks. Hipnosis

adalah ketika seseorang mampu memahami ide-ide tertentu untuk mencapai perubahan fisik, mental, dan spiritual yang diinginkan dan dilakukan dalam kondisi sadar yang terjadi secara alami (Asyima & Wulandari, 2021).

Hipnotherapy adalah cara untuk membantu seseorang mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hipnotherapy dapat membantu dan menyelesaikan banyak masalah karena fakta bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi manusia berasal dari pikiran mereka. Apabila pikiran kita tidak sehat, kita juga dapat mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang dapat menyebabkan masalah pada salah satu bagian tubuh kita atau masalah lain (Ma'rifah et al., 2021).

Hasil penelitian yang kami lakukan di RSUD Jombang pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 selama 4 minggu, menggunakan metode penelitian pre-eksperimental dengan rancangan penelitian one group pre dan post tes design. Penjarangan responden dilakukan di RSUD Kabupaten Jombang yang merupakan satu-satunya rumah sakit tipe B Pendidikan, dan merupakan rujukan regional. Penjarangan responden dilakukan untuk memperoleh responden ibu hamil yang usia kehamilan 26-28 minggu. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil usia kehamilan 26-28 minggu pada tanggal 23 April 2024 – 10 Mei 2024 di Poli Kandungan RSUD Kabupaten Jombang sejumlah 30 ibu hamil. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pengambilan sample berdasarkan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti, besar sampel 28 ibu hamil. Intervensi prenatal yoga dan hipnoterapi dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 selama 4 minggu, 2x60 menit dalam setiap minggunya setiap hari Rabu dan Jum'at. Sebelum dan sesudah melakukan prenatal yoga akan dilakukan pemeriksaan nyeri punggung dengan menggunakan

alat ukur skala nyeri numberik didapatkan bahwa Sebagian besar dari responden mengalami nyeri sedang sebelum diberikan prenatal yoga dan hipnoterapi, penurunan tingkat nyeri terlihat saat memasuki pertemuan ke 4, berangsur angsur turun dan terlihat hasilnya lebih baik lagi pada pertemuan ke 7. Penurunan skala nyeri punggung di Mombykids pada pertemuan ke tujuh seluruh responden mengalami nyeri ringan. Hasil penelitian menunjukkan nilai $\alpha = 0.00$, $p = 0.01$ dan $r = 0.702$ (hubungan kuat) artinya ada pengaruh yang signifikan antara Senam yoga dan hipnoterapi yang dilakukan secara benar dan teratur selama seminggu 2x selama 4 minggu berturut-turut terbukti dapat secara signifikan menurunkan skala nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III di Poli Kandungan RSUD Kabupaten Jombang.

Prenatal yoga dan hipnoterapi adalah kombinasi dari pernafasan dalam dan meditasi, jika dilakukan secara teratur dapat merengangkan otot dan menjaga kelenturan tulang belakang, meningkatkan aliran oksigen ke otak, sehingga bisa menurunkan nyeri punggung.

BAB 2

NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL

A. Definisi Nyeri Punggung

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan afektif yang bersifat negatif, yang muncul akibat adanya cedera atau kerusakan pada jaringan tubuh. Modalitas nyeri mencakup berbagai keluhan sensorik, seperti nyeri tajam, nyeri tumpul, hingga keluhan rematik. Secara biologis, nyeri memiliki fungsi protektif yang bertujuan melindungi individu dari bahaya dengan memicu respons adaptif. Manifestasi nyeri pada seseorang sering kali berdampak pada perubahan perilaku mereka sebagai upaya untuk mengurangi atau menghindari ketidaknyamanan tersebut. Dalam proses evaluasi nyeri, sangat penting untuk menjadikan kerusakan jaringan sebagai faktor utama yang perlu diperhatikan, karena hal ini sering menjadi pemicu utama timbulnya rasa sakit (Oktaviani, 2023).

Salah satu bentuk nyeri yang sering dialami oleh ibu hamil adalah nyeri punggung bawah, yang biasanya dikaitkan dengan beberapa perubahan biomekanik tubuh selama masa kehamilan. Salah satu faktor penyebab utama adalah peningkatan lordosis lumbal atau postur punggung yang melengkung ke depan secara berlebihan, yang muncul akibat adanya penyesuaian tubuh untuk mengakomodasi pertumbuhan janin di dalam rahim. Kondisi ini menyebabkan distribusi beban kerja pada otot-otot lumbal anterior dan posterior menjadi tidak seimbang, sehingga memicu ketegangan otot yang berujung pada timbulnya nyeri. Selain

itu, terdapat berbagai faktor predisposisi yang berkontribusi terhadap terjadinya nyeri punggung bawah selama kehamilan, di antaranya adalah peningkatan ukuran dan berat rahim yang mengakibatkan perubahan postur tubuh, bertambahnya berat badan secara signifikan, efek hormon relaksin yang menyebabkan peregangan pada ligamen dan sendi, riwayat nyeri punggung sebelum kehamilan, paritas atau jumlah kehamilan yang dialami sebelumnya, serta kurangnya aktivitas fisik selama masa kehamilan (Kumala, 2021; Oktaviani, 2023).

Nyeri punggung bawah atau *low back pain* (LBP) juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kondisi muskuloskeletal yang sering kali disebabkan oleh lemahnya otot-otot punggung akibat kurangnya aktivitas fisik. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun orientasi seksual, karena pada dasarnya setiap individu berpotensi merasakan ketidaknyamanan di area punggung bawah. Kebanyakan kasus nyeri punggung bawah disebabkan oleh otot-otot pinggang yang mengalami ketegangan akibat gerakan yang salah, postur tubuh yang buruk, atau mempertahankan posisi statis dalam jangka waktu yang lama, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan dan kekakuan pada otot. Secara anatomis, nyeri punggung bawah didefinisikan sebagai nyeri yang dirasakan di area superior, yang ditandai oleh garis imajiner horizontal yang melintasi ujung proses spinosus pada vertebra toraks terakhir, serta area inferior yang ditandai oleh garis horizontal yang melewati ujung vertebra sakral pertama dan dibatasi secara lateral oleh garis vertikal yang ditarik dari batas lateral tulang belakang lumbal (Kumala, 2021) .

Sekitar 70 persen wanita hamil mengalami nyeri punggung bawah, yang umumnya mulai dirasakan sejak trimester pertama dan mencapai puncaknya pada trimester kedua dan ketiga. Nyeri ini sering kali terasa di area lumbosakral, yaitu bagian bawah punggung yang menghubungkan tulang belakang dengan panggul. Kondisi ini dapat semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kehamilan, seiring dengan perubahan pusat gravitasi tubuh dan perubahan postur yang terjadi selama masa kehamilan. Peningkatan berat badan, pembesaran rahim, serta perubahan hormon yang mengarah pada pelonggaran ligamen dan sendi-sendi tubuh, juga dapat memperburuk rasa nyeri ini (Arummega, Rahmawati, & Meiranny, 2022).

Risiko terjadinya nyeri punggung bawah (Low Back Pain) pada kehamilan berikutnya cenderung lebih tinggi bagi ibu hamil yang sebelumnya sudah mengalami kondisi serupa. Mereka yang memiliki riwayat nyeri punggung bawah pada kehamilan sebelumnya lebih rentan mengalami masalah yang sama pada kehamilan berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara pengalaman nyeri punggung pada kehamilan sebelumnya dan kemungkinan terulangnya kondisi yang serupa pada kehamilan yang akan datang. Faktor-faktor seperti kelainan postur, pengaruh hormonal, dan penurunan kekuatan otot-otot inti yang mendukung tubuh selama kehamilan dapat berkontribusi terhadap tingginya risiko terjadinya nyeri punggung bawah pada ibu hamil yang memiliki riwayat serupa (Arummega, Rahmawati, & Meiranny, 2022)

Selama kehamilan, wanita hamil mengalami berbagai perubahan fisik yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, termasuk nyeri punggung, yang sering dirasakan terutama

pada tahap akhir kehamilan. Penyebab utama nyeri punggung pada ibu hamil adalah perubahan postur tubuh yang terjadi seiring dengan bertambahnya berat badan secara bertahap. Seiring dengan perkembangan janin, otot-otot perut yang sebelumnya kuat dan mendukung tubuh mulai meregang dan melemah, yang mengakibatkan perubahan posisi tubuh, seperti condong ke depan. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan otot di area panggul, yang pada gilirannya memicu terjadinya nyeri punggung bawah (Effect et al., 2018).

Nyeri punggung bawah pada ibu hamil bukan hanya masalah lokal, melainkan merupakan fenomena global yang ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa, Amerika, Australia, Cina, Taiwan, serta di daerah pedesaan pegunungan di Afrika. Bahkan, di kalangan wanita kelas atas di Nigeria, prevalensi nyeri punggung selama kehamilan juga cukup tinggi. Di Indonesia, survei terhadap ibu hamil menunjukkan bahwa sekitar 60-80% wanita hamil mengalami keluhan nyeri punggung bawah, yang menandakan bahwa kondisi ini merupakan masalah umum yang dialami oleh sebagian besar ibu hamil di berbagai wilayah (Effect et al., 2018).

Nyeri punggung bawah yang dialami ibu hamil dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, memengaruhi kualitas hidup, dan menurunkan produktivitas. Jika tidak ditangani dengan baik, nyeri ini bisa berkembang menjadi keluhan jangka panjang, yang bahkan dapat berlanjut hingga pascapartum. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk mengatasi nyeri punggung yang terjadi selama kehamilan dapat menyebabkan terjadinya nyeri punggung kronis yang jauh lebih sulit diatasi atau disembuhkan (Effect et al., 2018).

Meskipun pada umumnya gangguan nyeri punggung pada ibu hamil bersifat fisiologis atau normal, kondisi ini dapat berkembang menjadi patologis jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu hamil yang mengalami nyeri punggung untuk mendapatkan asuhan dan perawatan yang sesuai. Penanganan yang tepat, seperti latihan fisik yang aman, terapi fisik, pengaturan postur yang baik, serta penggunaan teknik relaksasi, dapat membantu meringankan nyeri dan mencegahnya berkembang menjadi masalah yang lebih serius (Effect et al., 2018).

Nyeri punggung selama kehamilan adalah salah satu keluhan yang paling umum dirasakan oleh ibu hamil, terutama pada trimester ketiga. Di Indonesia, sebuah penelitian yang melibatkan 180 ibu hamil menunjukkan bahwa sekitar 47 persen dari mereka mengalami nyeri punggung selama masa kehamilan (Melicha). Nyeri punggung ini sering kali menjadi masalah yang signifikan, mengganggu kenyamanan, dan mengurangi kualitas hidup ibu hamil (Kartikasari & Nuryanti, 2016).

Fenomena ini juga ditemukan secara luas di berbagai negara. Di Inggris dan Skandinavia, sekitar 50 persen ibu hamil melaporkan mengalami nyeri punggung, sementara di Australia, angka prevalensinya bisa mencapai 70 persen. Temuan serupa juga didapatkan oleh Mantle, yang melaporkan bahwa sekitar 16 persen wanita yang diteliti mengeluhkan nyeri punggung yang sangat berat, sementara 36 persen lainnya mengalami nyeri punggung dengan tingkat keparahan yang lebih rendah. Penyebab utama nyeri punggung pada ibu hamil berkaitan dengan perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan, seperti penambahan berat badan, perubahan pusat gravitasi tubuh, serta pelebaran dan

peregangan otot-otot di area perut dan punggung. Selain itu, perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan dapat melemahkan ligamen dan sendi-sendi tubuh, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya nyeri punggung (Kartikasari & Nuryanti, 2016).

Mengingat tingginya prevalensi nyeri punggung pada ibu hamil di berbagai belahan dunia, penting untuk memahami bahwa kondisi ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis ibu hamil. Oleh karena itu, penanganan yang tepat, termasuk latihan fisik, pengaturan postur, serta dukungan psikologis, sangat diperlukan untuk membantu ibu hamil mengatasi masalah ini dan mencegahnya berkembang menjadi gangguan jangka panjang (Kartikasari & Nuryanti, 2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2016, jumlah ibu hamil di Indonesia tercatat mencapai 5.354.594 orang. Di antara ibu hamil tersebut, prevalensi nyeri punggung bawah tercatat sebesar 18 persen, dengan angka ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Nyeri punggung bawah paling sering terjadi pada ibu hamil di usia dekade pertengahan hingga awal empat dekade (usia 30-an hingga 40-an). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap ibu hamil, ditemukan bahwa 12 orang ibu hamil melaporkan keluhan nyeri punggung bawah. Dari jumlah tersebut, sekitar 33,3 persen (empat orang) mengalami intensitas nyeri dengan skala tiga, yaitu nyeri yang cukup terasa tetapi masih dapat ditoleransi. Sebagian kecil (8,3 persen atau satu orang) melaporkan mengalami intensitas nyeri ringan (skala dua), yang hanya menimbulkan rasa tidak nyaman namun tidak mengganggu aktivitas secara

signifikan. Sementara itu, 25 persen (tiga orang) ibu hamil mengalami nyeri dengan intensitas tinggi (skala enam), yang digambarkan sebagai nyeri yang sangat kuat, tajam, dan dalam hingga mempengaruhi beberapa indera dan kualitas hidup mereka (Armayanti, Wardana, Pratiwi, & Pranata, 2023).

Peningkatan prevalensi nyeri punggung bawah pada ibu hamil ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor fisik yang terjadi selama kehamilan, seperti perubahan berat badan, perubahan postur tubuh, serta kelonggaran ligamen dan sendi yang disebabkan oleh perubahan hormonal. Selain itu, bertambahnya usia ibu hamil juga dapat memperburuk kondisi ini, mengingat tubuh cenderung kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap cedera atau ketegangan pada otot-otot dan sendi-sendi tubuh. Nyeri punggung bawah selama kehamilan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup ibu hamil, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta menambah tingkat stres atau kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengurangi intensitas nyeri dan mencegah terjadinya gangguan jangka panjang yang lebih serius. Pendekatan yang tepat, seperti latihan fisik yang aman, perbaikan postur tubuh, serta terapi fisik, dapat membantu meringankan gejala dan meningkatkan kenyamanan ibu hamil (Armayanti, Wardana, Pratiwi, & Pranata, 2023).

Prevalensi nyeri punggung bawah tinggi, dan wanita hamil mungkin memiliki riwayat medis sebelumnya yang mengalami ketidaknyamanan tersebut. Nyeri punggung bawah adalah kejadian umum selama kehamilan dan dianggap sebagai gangguan kecil pada kehamilan. Biasanya, gejala nyeri bermanifestasi antara bulan keempat dan

ketujuh kehamilan, dan nyeri terutama dialami di daerah punggung bawah. Kadang nyeri dapat menjalar ke pantat dan paha, bahkan sampai ke kaki. Pengalaman sakit punggung adalah kekhawatiran umum di kalangan wanita hamil. Sekitar 50-70% wanita hamil mampu merasakan sensasi yang dimaksud, seperti yang digambarkan pada gambar di atas. Sensasi sakit punggung dialami di semua tahap kehamilan. sensasi tersebut dominan dialami pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Ibu hamil trimester III sering mengalami rasa tidak nyaman berupa nyeri punggung. Insiden nyeri punggung bawah selama trimester awal kehamilan ditemukan sebesar 16,7%, meningkat menjadi 31,3% selama trimester kedua, dan selanjutnya meningkat menjadi 53% selama trimester ketiga. Telah diamati bahwa sebagian besar wanita, mulai dari 50% hingga 72%, cenderung mengalami eksaserbasi nyeri punggung bawah selama kehamilan seiring bertambahnya usia. Terjadinya nyeri punggung bawah pada ibu hamil pada trimester ketiga dikaitkan dengan rahim yang membesar, yang menyebabkan perubahan postur tubuh dan akibat pergeseran pusat gravitasi ke daerah anterior. Trimester ketiga kehamilan sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan yang paling umum, yaitu nyeri punggung. Terjadinya insomnia dan terganggunya aktivitas sehari-hari ibu pada masa nifas dapat menimbulkan masalah psikologis yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup ibu pada akhir kehamilan dan awal pascapersalinan, seperti dilansir Pennick (Oktaviani, 2023).

B. Etiologi

Nyeri punggung selama kehamilan terutama disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal yang terjadi pada tubuh ibu hamil, khususnya pada trimester ketiga, saat perkembangan janin yang semakin besar menyebabkan peningkatan berat badan ibu. Selain itu, peningkatan kadar hormon seperti relaxin yang berfungsi melunakkan ligamen dan sendi di area panggul, untuk mempersiapkan tubuh menghadapi proses persalinan, juga berkontribusi terhadap munculnya nyeri punggung. Perubahan tubuh yang berlangsung secara bertahap, disertai dengan kenaikan berat badan yang terus-menerus, menyebabkan postur tubuh ibu hamil berubah signifikan, yang pada gilirannya memengaruhi cara berjalan dan menambah beban pada struktur muskuloskeletal tubuh (Tettambel, 2010).

Menurut Tettambel, salah satu lokasi nyeri yang sering dialami oleh ibu hamil adalah pada sendi sakroiliaka, yaitu sendi yang menghubungkan tulang sakrum di panggul dengan tulang iliaka (tulang pinggul). Nyeri pada sendi sakroiliaka ini disebabkan oleh pembesaran janin yang menyebabkan tarikan pada jaringan dan otot di sekitar sendi tersebut. Seiring dengan perkembangan janin yang semakin besar dan perut yang semakin membesar, mobilitas sendi sakroiliaka meningkat, yang pada akhirnya memicu terjadinya nyeri. Tarikan ini dapat menyebabkan rasa sakit yang merambat hingga ke bagian belakang paha. Selain itu, distensi perut yang lebih lanjut akan semakin meningkatkan mobilitas sendi sakroiliaka, memperburuk rasa nyeri (Tettambel, 2010).

Selain nyeri pada sendi sakroiliaka, ibu hamil juga dapat mengalami nyeri pada bagian posterior pinggang, terutama pada daerah distal dan lateral dari lumbosakral

junction, yaitu area yang menghubungkan bagian bawah tulang belakang (lumbal) dengan tulang sakrum. Nyeri ini dapat menjalar hingga bagian belakang paha dan bahkan hingga ke atas lutut. Kondisi ini sering kali diidentifikasi sebagai sciatica atau posterior joint syndrome. Sciatica sendiri merupakan nyeri yang timbul akibat iritasi atau tekanan pada saraf sciatic, yang dapat menyebabkan rasa sakit yang menjalar sepanjang kaki, sementara posterior joint syndrome merujuk pada nyeri yang terkait dengan peradangan atau gangguan pada sendi di area panggul atau punggung bawah (Tettambel, 2010).

Nyeri punggung selama kehamilan, terutama yang berhubungan dengan sendi sakroiliaka dan lumbosakral junction, dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ibu hamil. Selain mengurangi kenyamanan, kondisi ini dapat menambah kecemasan atau stres, serta mempengaruhi kualitas hidup ibu selama kehamilan. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi gejala nyeri. Intervensi yang umum dilakukan meliputi terapi fisik, latihan penguatan otot inti dan panggul, serta pengaturan postur yang baik untuk mengurangi beban pada tulang belakang dan sendi panggul. Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bantu seperti sabuk penyangga kehamilan juga dapat membantu mengurangi tekanan pada punggung dan area panggul. Pada masa kehamilan, pusat gravitasi pada tubuh wanita akan bergeser dan pada masa akhir kehamilan dapat memicu terjadinya lordosis progresif. (Tettambel, 2010).

Menurut penelitian Whitcome, Shapiro, & Lieberman (2007), mengenai Kehamilan pada makhluk hidup berkaki dua, seperti manusia, memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan postur tubuh, khususnya di area tulang belakang.

Salah satu perubahan yang mencolok adalah meningkatnya lengkungan lordosis lumbal, terutama pada segmen L3 dan L4. Perubahan ini terjadi karena pergeseran pusat gravitasi tubuh (center of mass atau COM) akibat bertambahnya berat janin dan perubahan distribusi massa tubuh. Untuk menjaga stabilitas tubuh, ibu hamil secara alami mengadaptasi posturnya dengan ekstensi punggung, menghasilkan lengkungan lumbosakral yang lebih tajam. Di sisi lain, untuk menyeimbangkan perubahan tersebut, kurvatura atau lengkungan di daerah serviko-dorsal juga mengalami penyesuaian, berupa fleksi anterior kepala yang berlebihan. Selain itu, perubahan fisiologis seperti membesarnya payudara dan posisi bahu yang lebih condong ke depan saat berdiri semakin mempertegas lengkungan di area punggung dan lumbal. Akibatnya, struktur ligamen serta otot-otot di tulang belakang bagian tengah dan bawah mengalami tekanan yang lebih besar. Tekanan yang berlebihan ini sering kali menjadi pemicu nyeri punggung, terutama karena adanya tarikan pada saraf atau kompresi akar saraf, yang dikenal sebagai lordosis dorsolumbar progresif.

Peningkatan kelengkungan tulang belakang lumbal ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan pusat gravitasi tubuh. Hormon kehamilan, seperti progesteron dan relaksin, juga berkontribusi terhadap nyeri punggung bawah selama kehamilan. Progesteron, yang berfungsi untuk menenangkan otot polos di rahim, ureter, usus, dan lambung agar tidak berkontraksi, juga membantu memperkuat dinding panggul sebagai persiapan untuk persalinan. Namun, peningkatan produksi progesteron selama kehamilan dapat melunakkan sendi-sendi di area pinggang, yang menjadi salah satu faktor penyebab nyeri punggung. Relaksin, di sisi lain, berperan melonggarkan ligamen panggul untuk mempermudah

proses kelahiran, tetapi efeknya juga dapat memengaruhi stabilitas sendi tulang belakang, memperparah keluhan nyeri di daerah tersebut. Perubahan biomekanis dan hormonal ini menunjukkan betapa kompleksnya adaptasi tubuh wanita selama masa kehamilan, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan janin sekaligus mempersiapkan tubuh untuk persalinan. Namun, adaptasi ini sering kali disertai dengan berbagai tantangan fisik yang membutuhkan perhatian, seperti pengelolaan nyeri punggung melalui latihan, dukungan postural, dan strategi lain untuk mengurangi ketidaknyamanan (Manuaba, 2007).

Selain progesteron, hormon relaksin yang diproduksi oleh plasenta, khususnya di bagian desidua, juga berperan penting menjelang akhir masa kehamilan. Hormon ini bekerja sinergis dengan progesteron untuk mengurangi aktivitas kontraktile rahim, menjaga ketenangan otot polos, dan mempersiapkan leher rahim (serviks) untuk proses persalinan dengan melembutkan dan melonggarkan jaringan di sekitarnya. Fungsi utama relaksin pada tahap ini adalah membantu mempersiapkan jalan lahir agar bayi dapat dilahirkan dengan lebih mudah. Namun, efek relaksin tidak hanya terbatas pada area rahim dan serviks. Hormon ini juga memengaruhi seluruh persendian tubuh, terutama di bagian panggul. Relaksin menyebabkan ligamen dan jaringan ikat di sekitar persendian menjadi lebih lunak dan fleksibel. Efek ini dirancang untuk memungkinkan panggul meregang selama persalinan, tetapi sering kali disertai dengan dampak kurang nyaman, seperti nyeri panggul.

Selain panggul, hormon relaksin juga dapat memengaruhi stabilitas sendi lainnya di tubuh, seperti sendi tulang belakang dan lutut, karena ligamen yang melunak tidak lagi memberikan dukungan struktural yang optimal.

Akibatnya, beberapa wanita hamil mungkin mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri di berbagai bagian tubuh, terutama pada trimester ketiga ketika produksi relaksin mencapai puncaknya. Walaupun perubahan ini merupakan bagian dari adaptasi alami tubuh untuk kehamilan dan persalinan, efek samping seperti nyeri panggul atau ketidakstabilan sendi sering menjadi keluhan utama. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi ibu hamil untuk menjaga postur tubuh yang baik, melakukan latihan penguatan otot panggul dan punggung, serta menggunakan alat bantu seperti sabuk kehamilan jika diperlukan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi dan ligamen yang terpengaruh oleh hormon relaksin, sekaligus mendukung keseimbangan tubuh selama kehamilan (Sindhu, 2009).

Jika berat badan ibu hamil terus bertambah dan postur tubuh saat beraktivitas tidak dijaga dengan baik, mobilitas sendi-sendi seperti sakroiliaka, sakrokoksigeal, dan pubis akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama di bagian bawah punggung, yang menjadi semakin terasa menjelang akhir kehamilan. Pada trimester ketiga, keluhan seperti rasa pegal, mati rasa, dan kelemahan pada anggota tubuh bagian atas juga sering dialami. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya lengkungan lordosis di punggung bawah, disertai fleksi anterior leher dan posisi bahu yang lebih melengkung ke depan. Postur tersebut memberikan tekanan tambahan pada nervus ulnaris dan medianus, sehingga menimbulkan gejala-gejala tersebut di lengan dan tangan. (Cunningham, 2005).

Peningkatan berat badan yang berlebihan selama kehamilan dapat memberikan dampak signifikan pada postur tubuh ibu hamil. Posisi tubuh saat berdiri, duduk, berbaring, jongkok, atau ketika mengangkat benda berat

memiliki pengaruh besar terhadap munculnya nyeri punggung. Postur tubuh yang baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari sangat penting untuk mendistribusikan beban tubuh dengan optimal. Dengan postur yang benar, berat badan akan tersalurkan secara seimbang dari punggung bagian bawah ke pinggul, paha, kaki, hingga mencapai telapak kaki. Sebaliknya, postur tubuh yang buruk dapat mengganggu proses distribusi berat ini, menyebabkan akumulasi tekanan di area tertentu. Akibatnya, tekanan yang terlokalisasi ini sering kali menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan di punggung bawah, pinggul, bahkan lutut. Misalnya, saat berdiri dengan posisi membungkuk atau tanpa dukungan yang tepat, tekanan pada tulang belakang meningkat secara signifikan. Ketika duduk terlalu lama dengan postur tidak ergonomis, beban pada punggung bawah dan pelvis menjadi lebih besar, yang dapat memperparah rasa nyeri (Pradita A, 2010).

Selain itu, sikap tubuh yang kurang baik saat mengangkat benda berat, seperti membungkukkan punggung tanpa menekuk lutut, dapat menyebabkan cedera atau ketegangan pada otot-otot punggung. Ketegangan ini dapat menambah ketidaknyamanan yang sudah dialami ibu hamil akibat perubahan hormon dan distribusi beban selama kehamilan. Untuk mengurangi risiko nyeri dan meningkatkan kenyamanan, ibu hamil disarankan untuk menjaga postur tubuh yang baik. Ini termasuk berdiri tegak dengan berat badan merata pada kedua kaki, duduk dengan sandaran yang mendukung punggung bagian bawah, dan menghindari posisi statis yang terlalu lama. Latihan ringan seperti yoga atau senam kehamilan juga dapat membantu memperkuat otot-otot pendukung, meningkatkan fleksibilitas, dan meringankan ketegangan pada area

punggung dan pelvis. Dengan perhatian pada postur tubuh dan aktivitas sehari-hari, nyeri punggung yang sering dialami selama kehamilan dapat diminimalkan (Pradita A, 2010).

Hingga saat ini, penyebab pasti nyeri punggung selama kehamilan belum sepenuhnya dipahami. Namun, kondisi ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor alami yang melibatkan perubahan hormonal, vaskular, dan biomekanik selama kehamilan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kelebihan berat badan yang terjadi selama kehamilan memaksa otot bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan tekanan pada sendi dan menyebabkan stres pada tubuh ibu hamil. Selain itu, pembesaran rahim yang menggeser pusat gravitasi tubuh juga berkontribusi terhadap melemahnya otot-otot perut. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan pada punggung, menarik tulang belakang ke arah belakang, dan menyebabkan leher melengkung. Akibatnya, bagian bawah punggung menjadi lebih melengkung, sementara otot-otot punggung tertarik, yang sering kali menimbulkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan (Melicha).

Nyeri punggung selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, termasuk perubahan postur tubuh akibat pertumbuhan rahim dan perubahan komposisi tubuh secara keseluruhan. Perubahan ini dapat menghambat sinyal nyeri, menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan, dan berdampak pada ligamen akibat pengaruh hormon seperti relaksin. Selain itu, perubahan ini memengaruhi keseimbangan tubuh, aktivitas sehari-hari, serta riwayat ketidaknyamanan punggung sebelumnya. Salah satu penyebab umum nyeri selama kehamilan adalah peregangan ligamen yang menopang rahim, yang berkembang seiring bertambahnya usia kehamilan. Kondisi ini dikenal sebagai nyeri ligamen, dan sering menimbulkan rasa nyeri spasme

yang intens dan menyiksa. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut, termasuk tekanan pada punggung dan perubahan biomekanik, menjadi alasan utama ketidaknyamanan yang dirasakan ibu hamil selama masa kehamilan (Kartikasari & Nuryanti, 2016).

Nyeri punggung selama kehamilan dipengaruhi oleh berbagai faktor predisposisi. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan uterus yang mengakibatkan perubahan postur tubuh secara bertahap. Selain itu, peningkatan berat badan ibu hamil memberikan tekanan tambahan pada struktur tulang belakang dan otot pendukungnya. Faktor hormonal juga berperan besar, terutama hormon relaksin dan estrogen, yang memengaruhi ligamen serta jaringan penyangga lainnya. Hormon-hormon ini menyebabkan pelunakan dan peregangan ligamen sebagai persiapan tubuh untuk persalinan, tetapi juga berdampak pada stabilitas sendi. Faktor lain yang dapat memengaruhi nyeri punggung adalah riwayat nyeri punggung sebelumnya, jumlah kehamilan (paritas), serta tingkat aktivitas harian ibu hamil (Fraser, 2009).

Pada wanita hamil, nyeri punggung bawah sering kali diakibatkan oleh perubahan hormonal yang signifikan. Hormon estrogen dan relaksin berkontribusi terhadap perubahan pada jaringan lunak, termasuk otot, ligamen, dan jaringan penghubung. Akibatnya, elastisitas dan fleksibilitas jaringan ini menurun, membuat tubuh lebih rentan terhadap ketegangan dan rasa nyeri, terutama di area punggung bawah. Selain itu, kombinasi antara perubahan biomekanik, seperti pergeseran pusat gravitasi akibat pertumbuhan rahim, dan pengaruh hormon menyebabkan tekanan berlebih pada punggung. Postur tubuh yang berubah untuk mengakomodasi kehamilan sering kali membuat otot

punggung bekerja lebih keras, yang selanjutnya meningkatkan risiko kelelahan otot dan nyeri. Riwayat nyeri punggung sebelumnya juga memperburuk risiko ini, karena struktur punggung mungkin sudah mengalami kelemahan atau stres sebelumnya (Wahyuni, 2012).

Untuk mengurangi nyeri punggung selama kehamilan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Menjaga postur tubuh yang baik, rutin melakukan aktivitas fisik ringan seperti senam kehamilan atau yoga, serta menggunakan alat bantu seperti sabuk kehamilan dapat membantu mengurangi ketegangan pada punggung bagian bawah. Pendekatan ini juga bermanfaat dalam mempersiapkan tubuh untuk persalinan. Menurut Tyastuti (2016), beberapa faktor yang menyebabkan nyeri punggung bawah selama kehamilan meliputi ketegangan otot, kelelahan, posisi tubuh yang tidak tepat seperti membungkuk saat mengangkat barang, serta peningkatan kadar hormon yang melunakkan tulang rawan pada sendi-sendi besar. Selain itu, perubahan postural seperti hiperlordosis pada tulang belakang juga berkontribusi terhadap munculnya rasa nyeri (Wahyuni, 2012).

Ada berbagai cara untuk meringankan atau mencegah nyeri punggung selama kehamilan. Di antaranya adalah menghindari sikap hiperlordosis, tidak menggunakan sepatu atau sandal berhak tinggi, tidur di atas kasur yang mendukung tubuh dengan baik, menjaga postur yang benar, serta menghindari posisi membungkuk. Saat mengangkat barang, ibu hamil disarankan untuk menekuk lutut alih-alih membungkukkan punggung. Olahraga secara teratur, seperti senam kehamilan atau yoga, juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. Selain itu, menjaga kenaikan berat badan dalam rentang normal serta

melakukan pijatan lembut di punggung dapat membantu meredakan ketegangan (Wahyuni, 2012).

Menurut Brayshaw (2008), terdapat beberapa faktor predisposisi yang memicu nyeri punggung bawah (NPB) selama masa kehamilan. Faktor-faktor ini mencakup perubahan biomekanik akibat bertambahnya berat badan, pergeseran pusat gravitasi, kelemahan otot akibat tekanan hormonal, dan riwayat nyeri punggung sebelumnya. Identifikasi dini terhadap faktor-faktor ini memungkinkan ibu hamil untuk mengambil langkah pencegahan dan perawatan yang sesuai, sehingga risiko nyeri punggung dapat diminimalkan. Berikut merupakan faktor risiko nyeri punggung pada ibu hamil:

1. Penambahan berat badan yang drastis

Nyeri punggung bawah (NPB) sering terjadi pada ibu hamil selama trimester kedua hingga ketiga. Hal ini disebabkan oleh perubahan postur tubuh akibat peningkatan beban kandungan yang semakin besar, yang memperbesar sudut lengkungan tulang belakang. Penambahan sudut lengkungan ini menyebabkan menurunnya fleksibilitas dan mobilitas pada daerah lumbal. Nyeri punggung bawah terkadang dapat menjalar hingga ke panggul, paha, bahkan kaki, dan dalam beberapa kasus, nyeri ini juga terasa di area simpisis pubis. Gejala nyeri tersebut biasanya muncul bersamaan dengan bertambahnya berat badan ibu hamil.

2. Pertumbuhan uterus yang menyebabkan perubahan postur selama kehamilan

Seiring dengan pertumbuhan uterus, pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Hal ini memaksa ibu hamil untuk menyesuaikan postur tubuhnya saat berdiri. Perubahan ini membuat ibu hamil bergantung pada

kekuatan otot, peningkatan berat badan, fleksibilitas sendi, tingkat kelelahan, dan postur tubuh sebelum kehamilan. Postur yang tidak ideal akan memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang, menyebabkan peregangan otot yang berlebihan, kelelahan, dan pada akhirnya menimbulkan rasa nyeri di punggung bawah.

3. Peregangan Berulang

Postur tubuh yang kurang tepat juga dapat menyebabkan peregangan berulang pada otot dan ligamen, terutama di tulang belakang, pelvis, dan sendi yang menopang berat badan. Kondisi ini memicu kelelahan otot dan ligamen, yang berujung pada rasa sakit dan ketidaknyamanan di area tubuh tersebut.

4. Peningkatan kadar hormon estrogen terhadap ligamen

Nyeri punggung bawah selama kehamilan juga disebabkan oleh perubahan hormonal, terutama peningkatan kadar estrogen. Hormon ini memengaruhi jaringan lunak, termasuk ligamen dan jaringan penghubung (connective tissue). Akibatnya, elastisitas dan fleksibilitas otot serta ligamen menurun, yang membuat tubuh lebih rentan terhadap cedera atau rasa nyeri.

C. Proses Terjadinya Nyeri Punggung Bawah Kehamilan Trimester III

Proses terjadinya nyeri dimulai dari tahap transduksi, yaitu ketika reseptor nyeri (nosiseptor) di perifer tubuh dirangsang oleh berbagai jenis stimulus, seperti faktor biologis, mekanik, listrik, termal, radiasi, dan lainnya. Stimulus ini kemudian diubah menjadi sinyal nyeri oleh struktur khusus dalam sistem saraf. Sistem yang berperan dalam

transmisi dan persepsi nyeri dikenal sebagai sistem nosiseptif, yang sensitivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga intensitas nyeri yang dirasakan dapat berbeda pada setiap individu.

Nosiseptor, yang merupakan ujung saraf bebas di kulit, merespons hanya terhadap stimulus yang kuat atau berpotensi merusak, baik yang bersifat kimiawi, mekanis, maupun termal. Kornea dorsalis pada medula spinalis adalah area utama untuk pemrosesan sensorik. Agar nyeri dapat dirasakan secara sadar, neuron dalam sistem saraf ascenden harus diaktifkan.

Pada ibu hamil, nyeri punggung bawah sering terjadi karena pertumbuhan rahim yang menyebabkan perubahan postur tubuh. Perubahan ini meningkatkan tekanan pada lengkungan tulang belakang, sehingga otot-otot di bagian punggung bawah cenderung memendek. Proses ini memicu pelepasan mediator kimia, seperti prostaglandin dari sel-sel yang rusak, bradikinin dari plasma, histamin dari sel mast, dan serotonin dari trombosit. Peningkatan mediator-mediator tersebut merangsang aktivitas saraf simpatis, yang memperkuat sensasi nyeri. Nyeri dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jalur penghantarannya:

1. Nyeri cepat (fast pain), yang dipicu oleh stimulus mekanis atau termal, dihantarkan melalui serabut saraf A-Delta. Serabut ini bermielinasi, berukuran sedang, dan mampu menghantarkan nyeri dengan sangat cepat.
2. Nyeri lambat (slow pain), yang sering disebabkan oleh stimulus kimia, dihantarkan melalui serabut saraf C. Serabut ini tidak bermielinasi, berukuran kecil, dan menghantarkan sinyal nyeri dengan kecepatan yang jauh lebih lambat.

Kedua jenis serabut saraf ini bekerja secara sinergis dalam sistem nosiseptif untuk mengirimkan dan mengolah sinyal nyeri ke pusat-pusat otak, sehingga nyeri dapat dirasakan dan diproses. Serabut A-Delta bertugas menghantarkan sensasi nyeri yang tajam, terlokalisasi, dan mampu memberikan gambaran jelas tentang sumber nyeri serta intensitasnya. Sebaliknya, serabut C mengirimkan impuls nyeri yang bersifat tidak terlokalisasi, lebih menyebar (difus), viseral, dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai ilustrasi mekanisme kerja kedua serabut tersebut, misalnya ketika seseorang menginjak paku. Dalam waktu kurang dari satu detik setelah insiden, orang tersebut akan merasakan nyeri tajam yang terlokalisasi dengan baik. Sensasi ini dihasilkan oleh transmisi sinyal melalui serabut A-Delta. Sementara itu, serabut C akan bertanggung jawab atas sensasi nyeri yang bersifat lebih menyebar dan berkepanjangan setelahnya.

Tahap berikutnya dalam proses nyeri adalah transmisi, di mana impuls nyeri dihantarkan melalui serabut aferen (A-delta dan C) menuju medula spinalis melalui akar dorsal. Di medula spinalis, impuls tersebut akan bersinaps di substansia gelatinosa yang terletak pada lapisan I dan III. Setelah itu, impuls bergerak naik melalui traktus spinothalamicus anterior dan lateral. Sebagian impuls yang melalui traktus spinothalamicus lateral langsung diteruskan ke thalamus tanpa singgah di formasi retikularis, membawa sinyal fast pain. Di thalamus dan korteks serebri, individu akan dapat mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginterpretasikan, dan mulai merespons nyeri tersebut.

Beberapa impuls nyeri lainnya ditransmisikan melalui traktus paleospinothalamus yang berada di bagian tengah medula spinalis. Impuls ini kemudian memasuki formasi

retikularis dan sistem limbik, yang berperan dalam pengaturan emosi, perilaku kognitif, dan integrasi sistem saraf otonom. Nyeri lambat (slow pain) yang dihasilkan dapat memicu reaksi emosional, yang menyebabkan respons seperti terkejut, marah, cemas, peningkatan tekanan darah, keringat dingin, dan detak jantung yang meningkat (Prasetyo, 2010).

D. Faktor - faktor yang mempengaruhi nyeri punggung bawah trimester III pada kehamilan

Menurut Linden dan Ellyana (2012), terdapat beberapa faktor yang membuat ibu hamil pada trimester III lebih rentan mengalami nyeri punggung bawah. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Usia

Usia adalah durasi hidup seseorang sejak lahir dan menjadi salah satu penentu status kesehatan ibu hamil. Kehamilan dianggap berisiko tinggi jika dialami oleh ibu yang berusia di bawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Menurut Judha (2012), perbedaan perkembangan tubuh memengaruhi respons terhadap nyeri. Pada usia kurang dari 20 tahun, perkembangan fisik dan organ reproduksi belum sepenuhnya matang, sehingga tubuh belum siap untuk menjalani kehamilan. Selain itu, secara psikis, ibu muda cenderung kesulitan mengelola nyeri (Yanti, 2010). Sementara itu, pada usia lebih dari 35 tahun, fungsi fisik dan organ reproduksi mulai menurun, yang dapat memicu kecemasan terkait risiko kehamilan dan persalinan. Kecemasan ini dapat meningkatkan intensitas nyeri (Afritayeni, 2017).

2. Usia Kehamilan

Penelitian Ulfah (2014) menunjukkan bahwa keluhan nyeri punggung bawah sering terjadi pada trimester III kehamilan. Seiring bertambahnya usia kehamilan, perubahan postur tubuh terjadi akibat pergeseran pusat gravitasi ke depan. Jika otot perut tidak cukup kuat, hal ini dapat meningkatkan kelengkungan tulang belakang di daerah lumbar, yang kemudian menyebabkan nyeri punggung.

3. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan ibu hamil dapat memengaruhi tingkat kelelahan yang dialami. Menurut Yanti (2010), kelelahan berperan dalam memperburuk persepsi terhadap nyeri. Selain itu, kelelahan juga meningkatkan sensasi nyeri dan melemahkan kemampuan tubuh untuk mengatasinya.

4. Pendidikan Ibu

Tingkat pendidikan ibu berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan, termasuk nyeri punggung. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kesadarannya akan pentingnya kualitas kesehatan serta kemampuan mencari solusi untuk mengatasinya.

E. Akibat Nyeri Punggung Bagian Bawah

Nyeri punggung bawah yang dialami oleh ibu hamil dapat menghambat aktivitas sehari-hari secara signifikan. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi nyeri berkepanjangan, meningkatkan risiko nyeri punggung bawah pascapersalinan, dan bahkan nyeri punggung kronis yang sulit diatasi. Meskipun nyeri punggung bawah pada ibu hamil umumnya bersifat

fisiologis, kondisi ini dapat berubah menjadi masalah patologis jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu hamil yang mengalami nyeri punggung untuk menerima perawatan dan pengobatan yang tepat. Nyeri ini sering kali berdampak pada penurunan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Banyak wanita mengalami episode pertama nyeri punggung bawah selama kehamilan. Namun, kondisi ini sering diabaikan atau dianggap sebagai hal wajar dalam kehamilan. Nyeri punggung selama masa kehamilan juga dapat menyebabkan gangguan tidur, rasa takut, dan kecemasan, yang pada gilirannya meningkatkan stres dan memicu perubahan fisiologis yang signifikan.

F. Pengukuran Skala Nyeri

Novitasari dan Khoirunnisa (2015) mengemukakan bahwa skala penilaian uni-dimensi dan multi-dimensi dapat digunakan untuk menentukan dampak nyeri :

1. Skala Nyeri Uni-Dimensional
 - a. Mengukur intensitas nyeri saja
 - b. Cocok untuk nyeri akut
 - c. Skala yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pemberian analgesic
 - d. Skala penilaian nyeri satu dimensi ini meliputi: Visual Analogue Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), Numeric Rating Scale (NRS), Wong Baker Faces Pain Rating Scale.
2. Skala Nyeri Multi-Dimensional
 - a. Mengukur intensitas dan afektif nyeri
 - b. Diterapkan untuk nyeri kronis
 - c. Dapat digunakan untuk penilaian hasil klinis

- d. Skala multidimensi ini meliputi: McGill Pain Questionnaire (MPQ), The Brief Pain Inventory (BP 1), Memorial Pain Assessment Card, Pain Diary.

Skala penilaian numerik (Numeric Rating Scales/NRS) lebih sering digunakan sebagai pengganti alat deskripsi kata. Dalam hal ini klien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala yang paling efektif digunakan untuk menilai nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi terapeutik (Andarmoyo, 2013) dalam (Azimatul, 2021).

G. Teknik manajemen untuk nyeri punggung pada kehamilan

Teknik relaksasi didasarkan pada keyakinan bahwa tubuh memberikan respons terhadap kecemasan yang muncul akibat nyeri atau kondisi penyakit tertentu. Teknik ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan fisiologis yang terjadi. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan posisi kepala yang ditopang, baik dalam kondisi berbaring maupun duduk di kursi. Faktor utama dalam teknik relaksasi adalah memastikan klien berada dalam posisi nyaman, pikiran yang tenang, dan lingkungan yang mendukung suasana relaksasi (Asmadi, 2008). Salah satu metode relaksasi yang efektif dalam mengurangi nyeri adalah dengan mengatur pernapasan dalam dan melakukan relaksasi otot.

Untuk mengatasi nyeri punggung selama kehamilan, terdapat berbagai pilihan penanganan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Namun, penggunaan obat-obatan farmakologis sering kali memiliki risiko yang tidak baik bagi kehamilan. Sebagai contoh, pemberian Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) dilarang pada trimester ketiga kehamilan karena dapat memengaruhi janin, sedangkan penggunaan opioid dinilai

tidak aman bagi ibu hamil. Oleh karena itu, pendekatan non-farmakologis sering kali lebih disarankan karena dianggap lebih aman dan efektif. Beberapa metode non-farmakologis yang telah dikembangkan untuk menangani nyeri punggung pada kehamilan antara lain manipulasi jaringan lunak, latihan stabilisasi postur tubuh, dan stimulasi saraf listrik transkutan (TENS), yang umumnya dilakukan oleh tenaga profesional (Manyozo et al., 2019). Selain itu, salah satu metode non-farmakologis yang banyak diteliti dan terbukti efektif adalah prenatal yoga (Kinser et al., 2017; Rong et al., 2021; Wulandari et al., 2020).

Prenatal yoga adalah modifikasi dari gerakan yoga tradisional yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Gerakan dalam prenatal yoga dirancang dengan tempo yang lebih lambat dan disesuaikan dengan kapasitas gerak ibu hamil agar tetap aman dan nyaman. Yoga kehamilan bukan hanya sekadar latihan fisik, tetapi juga melibatkan aspek mental dan emosional. Latihan ini membantu melenturkan persendian, memperkuat otot, serta menenangkan pikiran ibu hamil. Dengan rutin melakukan prenatal yoga, ibu hamil akan merasa lebih rileks, mengurangi kecemasan, serta membawa suasana kehamilan yang lebih tenang. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan kebugaran fisik ibu, mengurangi ketegangan otot yang memicu nyeri punggung, dan memperkuat ikatan (bonding) antara ibu dan bayinya. Prenatal yoga juga berperan penting dalam mempersiapkan tubuh ibu hamil menghadapi persalinan. Dengan gerakan yang melibatkan teknik pernapasan, peregangan otot, dan meditasi, ibu hamil dapat melatih ketahanan fisik sekaligus meningkatkan kesiapan mental. Keuntungan lainnya adalah membantu mengurangi gangguan tidur dan stres yang sering dialami ibu hamil, sehingga secara keseluruhan dapat

meningkatkan kualitas hidup selama masa kehamilan (Gustina & Nurbaiti, 2020).

BAB 3

KOMBINASI PRENATAL YOGA DAN HIPNOTERAPI

A. Prenatal Yoga

Ibu hamil mengalami berbagai perubahan psikologis dan emosional selama kehamilan yang secara signifikan memengaruhi kesejahteraan mereka. Kondisi psikologis dan emosional ini akan mengalami perubahan yang dinamis seiring bertambahnya usia kehamilan, di mana ibu hamil kerap kali dihadapkan pada perasaan tidak nyaman atau gejala fisik yang mengganggu. Salah satu bentuk perubahan yang paling umum dialami adalah munculnya nyeri punggung. Nyeri ini sering kali terjadi secara progresif, di mana intensitasnya meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Kondisi ini menambah beban psikologis ibu, terutama ketika nyeri tersebut dirasakan terus-menerus atau terjadi dalam tingkat keparahan tertentu (Nurmitasari, 2022).

Nyeri punggung merupakan keluhan yang dialami oleh sebagian besar ibu hamil, terutama ketika mereka memasuki trimester kedua dan ketiga. Hal ini terjadi akibat perubahan biomekanis yang dialami tubuh ibu hamil dalam rangka menyesuaikan diri dengan pertumbuhan janin. Nyeri punggung yang dialami selama masa kehamilan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi menjadi masalah kesehatan yang lebih serius jika tidak segera ditangani. Apabila dibiarkan, nyeri punggung selama kehamilan dapat memicu nyeri jangka panjang yang

berlangsung hingga masa postpartum. Bahkan, kondisi ini dapat memperbesar risiko ibu mengalami nyeri kronis setelah melahirkan, yang dalam banyak kasus akan lebih sulit untuk disembuhkan karena melibatkan faktor fisik dan psikologis yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap keluhan ini agar dapat segera ditangani dengan tepat dan efektif, sehingga tidak berdampak buruk pada kualitas hidup ibu hamil maupun proses pemulihan pasca melahirkan. (Fazriani & Marwasariaty, 2024).

Dalam menangani keluhan nyeri punggung pada ibu hamil, tenaga kesehatan, terutama bidan, memiliki peran yang sangat penting. Bidan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan medis, tetapi juga harus mampu memahami teknik-teknik non-farmakologis yang aman dan efektif untuk mengurangi rasa sakit maupun ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil. Penggunaan metode non-farmakologis sangat dianjurkan karena tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya, baik bagi ibu maupun janin. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah imajinasi terbimbing, sebuah metode pengelolaan nyeri non-farmakologis yang terbukti efektif dalam membantu mengurangi ketidaknyamanan. Dalam dunia kesehatan, imajinasi terbimbing telah diterapkan melalui berbagai teknik, termasuk di antaranya adalah prenatal yoga, yang menjadi salah satu bentuk latihan fisik yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan ibu hamil (Nurmitasari, 2022).

Yoga merupakan bentuk latihan yang tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional. Latihan ini dirancang untuk membantu tubuh dan pikiran mencapai keadaan yang lebih seimbang, yang sangat

penting bagi ibu hamil yang kerap menghadapi perubahan besar selama kehamilan. Salah satu manfaat utama dari yoga adalah membantu menenangkan pikiran sekaligus merelaksasi persendian, terutama bagi ibu hamil yang memasuki trimester kedua dan ketiga, ketika ketidaknyamanan fisik akibat pertumbuhan janin cenderung meningkat. Gerakan-gerakan yoga yang dirancang khusus untuk ibu hamil dibuat lebih lambat, lembut, dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka selama masa kehamilan, sehingga aman untuk dilakukan tanpa menimbulkan risiko tambahan. Gerakan-gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki postur tubuh, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan punggung bagian bawah, yang menjadi salah satu area yang paling sering mengalami ketegangan selama kehamilan (Fazriani & Marwasariaty, 2024).

Prenatal yoga menjadi salah satu bentuk latihan yang sangat relevan bagi ibu hamil karena mencakup berbagai aspek, termasuk latihan fisik, mental, dan emosional. Dengan memadukan gerakan tubuh yang lembut, teknik pernapasan dalam, dan fokus pada kesadaran penuh, prenatal yoga membantu ibu hamil untuk mencapai kondisi tubuh dan pikiran yang lebih tenang. Selain itu, latihan ini memberikan manfaat tambahan berupa pengurangan stres, yang sering kali menjadi pemicu ketegangan otot pada punggung dan area lain. Prenatal yoga sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh ibu hamil yang memasuki trimester kedua dan ketiga, ketika ketidaknyamanan fisik akibat pertumbuhan janin biasanya mulai meningkat. Dengan pendekatan yang holistik ini, prenatal yoga menjadi salah satu metode yang tidak hanya efektif dalam mengurangi nyeri punggung tetapi juga

mendukung kesejahteraan emosional ibu hamil selama menjalani masa kehamilan mereka (Wulandari et al., 2020).

B. Hipnoterapi

Terdapat dua jenis terapi yang dapat digunakan dalam tindakan keperawatan untuk mengurangi atau menghentikan nyeri, diantaranya terapi farmakologis dengan memberikan analgesik yang berfungsi untuk menghentikan transmisi stimulus sehingga persepsi berubah, mengurangi reaksi kortikal terhadap nyeri. Sedangkan terapi non farmakologis mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri, seperti ketidakpercayaan, kesalahpahaman. Hipnoterapi adalah cara non-farmakologi lain untuk mengatasi nyeri. Perawat membantu dalam penanganan non-farmakologi ini. Hipnoterapi adalah bidang ilmu psikologis yang mempelajari bagaimana sugesti dapat membantu orang dengan masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Selama sesi hipnoterapi, kita akan diajarkan untuk memasuki keadaan trance atau relaksasi pikiran, sehingga pikiran kita lebih siap untuk menerima saran yang diberikan oleh terapis (Aprilyadi et al., 2020).

Hipnoterapi adalah upaya untuk menanamkan maksud dan sugesti positif ke dalam alam bawah sadar selama kehamilan dan persiapan persalinan. Ini dapat membantu mengurangi nyeri dan stres, membuat ibu lebih tenang saat persalinan (Nurmitasari, 2022). Salah satu manfaat hipnoterapi pada ibu hamil adalah memberikan saran berupa afirmasi atau kalimat perintah agar subjek hipnosis dapat segera masuk ke alam pikiran bawah sadar, yang membuat ibu rileks. Hipnosis adalah ketika seseorang mampu memahami ide-ide tertentu untuk mencapai perubahan fisik, mental, dan spiritual yang diinginkan dan dilakukan dalam

kondisi sadar yang terjadi secara alami (Asyima & Wulandari, 2021).

Hipnotherapy adalah cara untuk membantu seseorang mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hipnotherapy dapat membantu dan menyelesaikan banyak masalah karena fakta bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi manusia berasal dari pikiran mereka. Apabila pikiran kita tidak sehat, kita juga dapat mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang dapat menyebabkan masalah pada salah satu bagian tubuh kita atau masalah lain (Ma'rifah et al., 2021).

Hipnotherapy dapat mengurangi tingkat nyeri punggung pada ibu hamil karena hipnotherapy mempengaruhi sistem limbik dan saraf otonom, menciptakan suasana yang tenang, aman, dan menyenangkan. Hipnotherapy merangsang pusat rasa gajangan dan melepaskan substrat kimia gamma amino butyric acid (GABA), enkephalin, dan endorphin, yang menghilangkan neurotransmitter nyeri. Hipnotherapy, sejenis pengobatan non medis, adalah salah satu bentuk self-hypnosis yang paling efektif untuk mengurangi ketegangan dan rasa sakit. Hipnotherapy bekerja untuk menenangkan pikiran dan otot, meregangkan dan mengendurkan mereka, dan mengatur pernapasan untuk memicu respons relaksasi (Adiningtya & Prasetyorini, 2024). Relaksasi hipnotherapy akan menuntun agar ibu hamil tetap dalam kondisi rileks dan sama sekali tidak memikirkan dan merasakan nyeri punggung yang ditimbulkan dari peningkatan usia kehamilan dan peningkatan berat janin dalam kandungan (Asyima & Wulandari, 2021).

C. Prenatal Yoga dan Hipnoterapi sebagai Metode Terintegrasi untuk Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan

Hipnoterapi merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang banyak digunakan dalam psikiatri dan memiliki cakupan penggunaan yang luas, termasuk dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Model pengobatan ini telah terbukti efektif dalam membantu mengelola berbagai masalah fisik dan emosional, seperti nyeri punggung, stres, dan kecemasan, yang sering kali dialami selama kehamilan. Dalam konteks pengelolaan nyeri punggung pada ibu hamil, hipnoterapi dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti prenatal yoga untuk meningkatkan efektivitasnya. Kombinasi ini dirancang untuk bekerja secara sinergis, di mana prenatal yoga memberikan manfaat fisiologis melalui latihan fisik yang terfokus pada fleksibilitas dan pernapasan, sementara hipnoterapi memberikan efek psikologis melalui relaksasi mendalam yang membantu mengelola persepsi nyeri dan menciptakan rasa nyaman (Pramesti et al., 2023).

Hipnoterapi bekerja dengan cara yang unik, yaitu menurunkan tingkat kesadaran sensorik ibu hamil sambil meningkatkan konsentrasi dan sugestibilitas mereka. Dalam kondisi hipnosis, ibu hamil menjadi lebih terbuka terhadap sugesti yang bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri, meningkatkan rasa tenang, dan membantu mereka merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan kehamilan. Proses ini memungkinkan ibu hamil untuk lebih fokus pada teknik relaksasi yang diajarkan, sehingga mereka dapat mengatasi rasa tidak nyaman yang muncul selama kehamilan dengan lebih efektif. Kombinasi hipnoterapi dan prenatal yoga memperkuat manfaat dari kedua metode ini, menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya

mengatasi keluhan fisik seperti nyeri punggung, tetapi juga mendukung keseimbangan emosional dan mental ibu hamil (Pramesti et al., 2023).

Dengan memberikan pelatihan kepada ibu hamil tentang cara melakukan self-hipnosis di rumah, hipnoterapi menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam memberikan kemandirian kepada ibu untuk mengelola kesehatan mereka sendiri. Ibu hamil yang terlatih dalam teknik ini dapat menggunakan hipnoterapi sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengatasi nyeri punggung atau gejala kehamilan lainnya yang mungkin timbul, tanpa harus selalu bergantung pada intervensi eksternal. Pendekatan ini juga memungkinkan mereka untuk merasa lebih terlibat dalam proses kehamilan mereka, meningkatkan rasa kontrol atas tubuh mereka, dan menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih positif dan memuaskan (Pramesti et al., 2023).

Lebih jauh lagi, hipnoterapi memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai bagian dari kelas ibu hamil yang diselenggarakan di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, hipnoterapi dapat diajarkan bersama dengan prenatal yoga sebagai kombinasi terapi yang saling melengkapi. Prenatal yoga memberikan manfaat langsung pada tubuh dengan meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki postur, dan meredakan ketegangan otot, sedangkan hipnoterapi membantu ibu hamil mencapai kondisi relaksasi mendalam yang mempercepat proses pemulihan dari rasa tidak nyaman. Kombinasi ini tidak hanya membantu ibu hamil dalam mengelola nyeri punggung tetapi juga memberikan efek jangka panjang yang mendukung kesehatan fisik dan mental mereka selama kehamilan dan pasca melahirkan (Halim & Khayati, 2020).

Dengan mengintegrasikan prenatal yoga dan hipnoterapi ke dalam program kehamilan, tenaga kesehatan dapat menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendukung kesejahteraan ibu hamil. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda, tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit tetapi juga meningkatkan kesiapan mental ibu dalam menghadapi persalinan. Prenatal yoga dan hipnoterapi dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan individu, menjadikannya solusi yang fleksibel dan mudah diakses oleh berbagai kelompok ibu hamil. Dengan dukungan dari instruktur yoga bersertifikat dan praktisi hipnoterapi yang terlatih, kombinasi metode ini dapat diterapkan di kelas ibu hamil maupun secara mandiri di rumah, memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hipnoterapi, terutama ketika dikombinasikan dengan prenatal yoga, menawarkan pendekatan inovatif yang aman dan efektif untuk mendukung kesehatan ibu hamil. Metode ini tidak hanya membantu meredakan nyeri punggung, tetapi juga memberikan ibu hamil alat yang kuat untuk mengelola tantangan kehamilan secara mandiri. Dengan potensi besar untuk diterapkan di berbagai lingkungan, dari rumah hingga fasilitas kesehatan, kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi menjadi pilihan yang relevan untuk mendukung kesehatan ibu hamil secara holistik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih nyaman dan positif (Halim & Khayati, 2020). Berikut merupakan tahapan dalam melakukan kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi:

1. Persiapan alat

- a. Matras yoga
- b. Bantal

2. Prenatal Yoga

a. Duduk Sukhasana

Duduk bersila dengan posisi tubuh yang nyaman, punggung lurus, dan kepala menghadap ke depan. Mulailah dengan memutar bahu ke arah belakang sebanyak enam kali secara perlahan. Gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot bahu dan punggung atas, yang sering kali tegang selama kehamilan.

b. Centering/Pranayama

Saat duduk bersila dengan punggung tegak, pusatkan perhatian pada tubuh, pernapasan, dan pikiran Anda. Letakkan tangan kiri di perut untuk merasakan gerakan janin dan tangan kanan di dada untuk memantau ritme pernapasan. Dengan memanjangkan tulang belakang, cobalah merasakan setiap sensasi di tubuh Anda, dari napas yang masuk hingga pergerakan janin. Fokus ini membantu menciptakan ikatan yang lebih dalam antara ibu dan bayi serta memberikan rasa tenang.

c. *Side Head*

Duduk dalam posisi bersila dengan tangan kanan memegang telinga kiri. Perlahan arahkan kepala ke kanan dan tahan posisi ini selama lima hitungan. Setelah itu, ulangi gerakan ke arah sebaliknya. Latihan ini membantu mengurangi ketegangan pada leher dan bahu. Ulangi masing-masing sisi hingga tiga kali untuk hasil optimal.

d. *Head Up and Down*

Duduk bersila dengan punggung tegak dan kedua telapak tangan direkatkan di depan dada, dengan ujung jempol menyentuh dagu. Jaga bahu tetap santai dan jauh dari telinga. Dongakkan kepala perlahan-lahan, arahkan pandangan ke atas sambil menarik

napas, dan dorong dagu ke atas. Saat menghembuskan napas, kembalilah ke posisi semula. Gerakan ini dilakukan secara perlahan untuk meregangkan otot leher.

e. *Head Round*

Dalam posisi duduk bersila dengan punggung lurus, tundukkan kepala ke depan secara perlahan. Lakukan gerakan memutar kepala ke samping, ke belakang, dan kembali ke depan sambil menarik dan menghembuskan napas. Ulangi siklus ini hingga tiga kali. Latihan ini membantu melenturkan otot leher dan bahu.

f. *Easy Armn Up and Down*

Gerakan ini dimulai dengan memutar bahu ke arah luar dan belakang untuk membuka area dada. Tarik napas sambil memutar tangan di sekitar bahu, lalu buang napas sambil memutar bahu ke dalam. Pose ini membantu melancarkan aliran darah di area bahu dan dada, memberikan kenyamanan bagi ibu hamil.

g. *Pelvic Rotation*

Letakkan kedua tangan di pinggang untuk mendukung tubuh. Tarik napas sambil memutar pinggul ke arah belakang. Buang napas, lalu lanjutkan gerakan memutar dari belakang hingga ke samping dan kembali ke depan. Pelvic rotation membantu melenturkan otot-otot panggul, yang penting untuk persiapan persalinan.

h. *Gentle Twist*

Dalam posisi duduk bersila, tarik napas dalam-dalam sambil memanjangkan tulang belakang. Letakkan tangan kanan di belakang tubuh dan buang napas sambil memutar tubuh perlahan ke arah kanan. Ulangi

gerakan ini ke arah kiri untuk menyeimbangkan peregangan di kedua sisi tubuh.

i. *Side Elbow*

Arahkan tangan kanan ke atas dan tekuk siku kanan hingga mengarah ke langit-langit. Gunakan tangan kiri untuk menarik siku kanan perlahan, lalu tahan posisi ini selama 3–5 siklus pernapasan. Ulangi pada sisi sebaliknya untuk melenturkan otot bahu dan punggung atas.

j. *Side Stretch Up*

Tarik tangan kiri ke atas sambil menarik napas, lalu condongkan tubuh ke arah kanan. Hembuskan napas dan biarkan sisi tubuh memanjang, dengan pandangan mengarah ke telapak tangan kiri. Tahan posisi ini selama 3–5 siklus pernapasan, lalu ulangi untuk sisi lainnya.

k. *Upavista Side Stretch*

Duduk dengan kedua kaki terbuka lebar di depan tubuh. Pegang ujung jari kaki kanan dengan tangan kanan, lalu tarik tangan kiri ke atas sambil menarik napas. Panjangkan tubuh ke sisi kiri sambil menahan posisi selama 3–5 siklus pernapasan. Lakukan gerakan ini secara bergantian untuk sisi kanan dan kiri.

l. *Table Pose*

Mulailah dengan posisi merangkak, dengan kedua tangan sejajar bahu dan telapak tangan menempel di matras. Pastikan lutut sejajar dengan pinggul untuk mendukung postur yang stabil. Pose ini mempersiapkan tubuh untuk gerakan selanjutnya.

m. *Cat Cow Pose*

Dari posisi merangkak, tarik napas sambil membuka dada dan mengarahkan pandangan ke atas. Saat

menghembuskan napas, lengkungkan punggung ke belakang, tundukkan kepala, dan arahkan pandangan ke perut. Ulangi gerakan ini beberapa kali untuk mengurangi ketegangan pada punggung.

n. *Gentle Supine Spiral Twist*

Berbaring telentang dengan kedua kaki ditekuk. Rentangkan kedua tangan ke samping sejajar bahu. Tarik napas dalam-dalam, lalu buang napas sambil mengarahkan kedua lutut ke kanan. Tahan posisi ini selama beberapa siklus pernapasan dan ulangi pada sisi sebaliknya.

o. *One Leg-to-Chest Pose*

Tetap dalam posisi telentang. Lipat lutut kanan ke arah dada sambil menarik napas. Gunakan tangan kanan untuk memegang lutut, lalu buang napas sambil menarik lutut lebih dekat ke dada. Ulangi gerakan ini untuk sisi kiri.

p. *Corpse Pose*

Akhiri sesi yoga dengan berbaring miring ke kiri. Gunakan bantal untuk menopang lutut guna menjaga kenyamanan dan panggul tetap terbuka. Luangkan waktu untuk merelaksasikan tubuh sepenuhnya, mempersiapkan sesi hipnoterapi berikutnya.

3. Hipnoterapi

Silakan duduk atau berbaring dengan posisi yang benar-benar nyaman. Pastikan tubuh Anda dalam keadaan rileks, tanpa tekanan, dan dukung bagian punggung serta kepala Anda dengan bantal jika perlu. Perlahan, pejamkan mata Anda. Biarkan kelopak mata Anda terasa berat, seolah-olah ingin beristirahat.

Sekarang, tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan udara segar mengisi paru-paru Anda, memenuhi

tubuh Anda dengan ketenangan. Kemudian, buang napas perlahan melalui mulut. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan semua ketegangan, kekhawatiran, atau stres perlahan-lahan keluar dari tubuh Anda. Lakukan ini sekali lagi, dengan lebih dalam, lebih lembut. Rasakan gelombang ketenangan mulai menjalar dari kepala hingga ujung kaki.

Sekarang, alihkan perhatian Anda pada tubuh Anda. Mulailah dari bagian kepala. Bayangkan otot-otot di dahi Anda melonggar, kelopak mata Anda terasa semakin berat, dan wajah Anda menjadi sepenuhnya santai. Rasakan rahang Anda melunak, membiarkan mulut Anda sedikit terbuka untuk melepaskan semua ketegangan di area tersebut.

Lalu, arahkan perhatian Anda ke leher dan bahu. Dengan setiap tarikan napas, rasakan bahu Anda turun perlahan, semakin jauh dari telinga Anda, menjadi lebih santai. Bayangkan sebuah gelombang kehangatan melewati leher Anda, melonggarkan setiap otot yang terasa tegang.

Sekarang, rasakan punggung Anda mulai rileks. Mulai dari tulang belakang bagian atas, turun perlahan ke tengah punggung, hingga ke punggung bawah. Bayangkan cahaya hangat seperti sinar matahari pagi yang lembut menyentuh punggung Anda. Cahaya ini meredakan ketegangan, membawa rasa nyaman yang dalam.

Arahkan perhatian Anda ke lengan dan tangan. Rasakan tangan Anda menjadi ringan, seolah-olah tidak perlu menahan apa pun. Setiap jari terasa hangat, rileks, dan bebas. Lanjutkan ke dada, di mana napas Anda mengalir dengan lembut. Rasakan dada Anda

mengembang dengan penuh cinta dan energi positif saat Anda menarik napas, dan melepaskan semua ketegangan saat Anda menghembuskannya.

Sekarang, fokuslah pada area perut Anda. Perhatikan gerakan halus yang terjadi di sana—gerakan kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Rasakan koneksi dengan bayi Anda, perasaan yang indah dan hangat yang menyatukan Anda berdua.

Bayangkan diri Anda berada di tempat yang sangat tenang dan damai. Mungkin sebuah taman yang dipenuhi bunga dengan aroma yang harum, pantai dengan suara ombak lembut yang menyentuh pasir, atau tempat lain yang membuat Anda merasa bahagia. Apa pun tempat itu, lihatlah dengan jelas dalam pikiran Anda. Perhatikan setiap detailnya, warna, suara, aroma, bahkan sensasi angin yang menyentuh kulit Anda.

Di tempat ini, Anda merasa benar-benar aman. Tidak ada yang mengganggu Anda. Tidak ada beban yang Anda bawa. Anda hanya merasakan kebebasan, kedamaian, dan cinta yang melingkupi diri Anda.

Rasakan cahaya hangat menyelimuti tubuh Anda. Cahaya ini perlahan turun ke punggung Anda, mulai dari bahu hingga ke punggung bawah. Cahaya ini memberikan rasa nyaman, hangat, dan lembut, seolah-olah menghapus semua rasa nyeri atau ketidaknyamanan.

Dalam keadaan yang sangat tenang ini, ingatkan diri Anda bahwa Anda adalah ibu yang kuat. Tubuh Anda dirancang secara sempurna untuk mendukung Anda dan bayi Anda selama perjalanan kehamilan ini. Setiap tarikan napas yang Anda ambil membawa ketenangan ke seluruh tubuh, sementara setiap hembusan napas membawa

pergi semua rasa nyeri, ketidaknyamanan, atau kekhawatiran.

Bayangkan punggung Anda semakin nyaman. Otot-otot Anda bekerja selaras, melepaskan semua ketegangan, dan memberikan dukungan yang maksimal untuk tubuh Anda. Anda merasakan rasa ringan, rileks, dan nyaman yang semakin meningkat seiring waktu.

Fokuskan perhatian Anda kembali pada bayi Anda. Bayangkan setiap rasa nyaman yang Anda rasakan ini juga dirasakan oleh bayi Anda. Setiap tarikan napas membawa cinta, ketenangan, dan energi positif kepada bayi Anda. Bayangkan hubungan harmonis yang sempurna antara Anda dan bayi Anda, penuh dengan kehangatan dan cinta tanpa syarat.

Ketika Anda merasa siap, mulailah membawa perhatian Anda kembali ke ruangan ini. Rasakan tubuh Anda tetap rileks, namun dengan energi positif yang mulai mengalir. Tarik napas dalam-dalam satu kali lagi, dan hembuskan perlahan.

Gerakkan jari-jari tangan dan kaki Anda secara perlahan. Rasakan setiap gerakan membawa Anda kembali ke kesadaran penuh. Saat Anda membuka mata, biarkan diri Anda merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih damai. Anda sekarang siap menghadapi hari dengan rasa tenang dan energi baru, mengetahui bahwa tubuh Anda kuat dan bayi Anda terlindungi dengan sempurna.

BAB 4

PERAN PRENATAL YOGA DAN HIPNOTERAPI

A. Hasil Integrasi

Penurunan nyeri punggung melalui prenatal yoga dapat dijelaskan melalui adaptasi fisiologis yang terjadi pada tubuh ibu hamil selama masa kehamilan. Ketika janin tumbuh dan berat badannya meningkat, tubuh ibu secara alami berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Proses adaptasi ini melibatkan pergeseran pusat gravitasi tubuh, yang mengakibatkan bahu tertarik ke belakang, lengkungan pada tulang belakang semakin meningkat, dan sendi-sendi tulang belakang menjadi lebih fleksibel. Kondisi ini bertujuan untuk mempersiapkan tubuh ibu menghadapi persalinan. Namun, perubahan biomekanis tersebut sering kali menjadi salah satu penyebab utama nyeri punggung, terutama pada punggung bagian bawah (Nur Arummega et al., 2022).

Nyeri punggung bawah adalah salah satu keluhan yang paling umum dialami oleh ibu hamil, khususnya selama trimester kedua dan ketiga. Sekitar 70% wanita hamil diketahui mengalami berbagai tingkat nyeri punggung selama masa kehamilan. Kondisi ini bahkan sering kali berlanjut hingga masa persalinan dan postpartum, menyebabkan ketidaknyamanan yang berkepanjangan dan berdampak pada kualitas hidup ibu. Nyeri punggung yang muncul disebabkan oleh redistribusi berat badan, tekanan

yang meningkat pada tulang belakang, serta ketidakseimbangan biomekanis yang memengaruhi postur tubuh secara keseluruhan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan rasa sakit fisik, tetapi juga dapat memperburuk stres emosional ibu hamil jika tidak dikelola dengan baik (Nur Arummega et al., 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi memberikan pendekatan yang terintegrasi untuk membantu ibu hamil mengelola nyeri punggung dengan cara yang aman dan efektif. Prenatal yoga berfokus pada latihan-latihan yang membantu meningkatkan fleksibilitas otot, memperbaiki postur tubuh, dan meredakan ketegangan di area punggung. Melalui latihan peregangan ringan, ibu hamil diajarkan untuk mengurangi ketegangan otot yang disebabkan oleh perubahan fisiologis selama kehamilan. Selain itu, teknik pernapasan dalam yang menjadi bagian penting dari prenatal yoga membantu meningkatkan relaksasi, memungkinkan ibu hamil untuk merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, hipnoterapi memberikan manfaat psikologis yang memperkuat efek positif dari prenatal yoga. Terapi ini memungkinkan ibu hamil untuk mencapai kondisi relaksasi mendalam yang membantu mereka mengelola stres, kecemasan, serta persepsi nyeri dengan lebih baik. Hipnoterapi bekerja dengan cara mengurangi respons otak terhadap sinyal rasa sakit dan meningkatkan produksi dopamin, sehingga menciptakan perasaan nyaman yang lebih mendalam. Melalui kombinasi manfaat fisiologis dan psikologis ini, prenatal yoga dan hipnoterapi tidak hanya membantu mengurangi nyeri punggung secara fisik tetapi juga memberikan dukungan emosional yang signifikan bagi

ibu hamil selama masa kehamilan (Nur Arummega et al., 2022).

Dengan demikian, kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi menjadi pendekatan yang tidak hanya berfungsi untuk mengatasi keluhan fisik tetapi juga mendukung kesehatan mental ibu hamil secara keseluruhan. Metode ini membantu ibu hamil untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan, meminimalkan risiko nyeri yang berkepanjangan, dan menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih positif dan berkualitas. Penerapan prenatal yoga dan hipnoterapi secara konsisten tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi ibu hamil tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama masa kehamilan.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa prenatal yoga dan hipnoterapi dapat menjadi bagian penting dalam program kesehatan kehamilan yang lebih holistik. Pendekatan ini memberikan ibu hamil manfaat jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis, menjadikannya solusi yang relevan dan aman untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan selama kehamilan (Nur Arummega et al., 2022).

B. Pendekatan Holistik dalam Mengatasi Nyeri Punggung pada Ibu Hamil

Selama masa kehamilan, terjadi berbagai perubahan signifikan dalam tubuh ibu, termasuk relaksasi pada sendi panggul akibat meningkatnya hormon estrogen, progesteron, dan relaksin. Hormon estrogen, khususnya, berperan dalam melembutkan jaringan ikat, sehingga membuat kapsul sendi menjadi lebih rileks dan memungkinkan pergerakan sendi panggul lebih fleksibel.

Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan tubuh ibu dalam menghadapi persalinan, namun sering kali menyebabkan ketidaknyamanan fisik, termasuk nyeri punggung bawah (Nur Arummeqa et al., 2022).

Prenatal yoga merupakan modifikasi dari yoga klasik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik ibu hamil. Latihan ini berfokus pada dasar-dasar postur tubuh serta teknik pernapasan dalam, yang memberikan banyak manfaat baik secara fisiologis maupun psikologis. Salah satu manfaat utama dari latihan pernapasan dalam pada prenatal yoga adalah membantu ibu hamil untuk lebih tenang, mengendalikan emosi, dan memusatkan perhatian pada kondisi tubuh serta pikiran saat ini. Proses ini menjadi bagian penting dari pengendalian diri, di mana ibu hamil berusaha untuk mengatur respons emosional dan perilaku mereka dalam menghadapi perubahan fisik selama kehamilan. Selain itu, praktik prenatal yoga memberikan kesempatan bagi ibu hamil untuk mendapatkan dukungan sosial dari sesama peserta dan instruktur yoga, yang secara tidak langsung meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi tingkat stres (Dewi Rosita et al., 2022; Wulansari, 2021).

Sebagai metode self-help yang bermanfaat, prenatal yoga telah terbukti efektif dalam mengurangi ketidaknyamanan fisik, terutama nyeri punggung yang sering dialami ibu hamil. Latihan ini direkomendasikan untuk dimulai sejak minggu ke-20 kehamilan dengan frekuensi 2-3 kali per minggu untuk hasil yang optimal (Rosmadewi & Rudiyantri, 2018). Namun, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam yoga prenatal, seperti menghindari tekanan langsung pada perut, peregangan yang berlebihan di sekitar area perut, serta gerakan memutar yang dapat memengaruhi keseimbangan. Hal ini

disebabkan oleh peningkatan hormon relaksin yang membuat persendian lebih lentur dan rentan cedera, sehingga ibu hamil perlu berhati-hati dalam melakukan gerakan agar tidak mengalami cedera (Adnyani, 2021).

Selain itu, penting untuk diingat bahwa ibu hamil mengalami peningkatan volume darah dan cairan tubuh selama kehamilan, yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, latihan prenatal yoga harus dilakukan dengan intensitas yang sesuai, tanpa memaksakan tubuh, agar tidak membebani jantung secara berlebihan yang dapat memicu sesak napas atau kelelahan (Adnyani, 2021).

Sementara itu, hipnoterapi merupakan metode terapi non-farmakologis yang sangat efektif untuk membantu mengatasi berbagai masalah fisik dan psikologis. Hipnoterapi bekerja dengan cara menjangkau pikiran bawah sadar, mendidik ulang pikiran, dan memberikan solusi jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan nyeri, hipnoterapi membantu menghalangi sinyal rasa sakit untuk mencapai area otak yang memproses persepsi nyeri, melalui perubahan aktivitas di struktur kortikal otak. Peningkatan aktivitas dopaminergik yang dihasilkan selama hipnoterapi juga membantu menekan persepsi nyeri, sehingga pasien merasakan pengurangan rasa sakit secara signifikan (Ramadhan et al., 2024).

Gabungan prenatal yoga dan hipnoterapi menciptakan pendekatan yang holistik untuk meredakan nyeri punggung pada ibu hamil. Prenatal yoga berperan dalam merelaksasi tubuh secara fisiologis, dengan meningkatkan fleksibilitas otot dan memperbaiki postur tubuh, sedangkan hipnoterapi fokus pada pengelolaan nyeri dari sisi psikologis. Kombinasi ini membantu ibu hamil untuk merasa lebih rileks, baik secara

fisik maupun mental, sehingga menghasilkan efek yang lebih konsisten dalam pengurangan nyeri.

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi yang dilakukan secara rutin, yaitu dua kali seminggu selama empat minggu, memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Pada minggu pertama hingga ketiga, tingkat nyeri mulai menurun secara perlahan, sementara perbaikan signifikan terlihat pada pertemuan keempat. Hasil terbaik tercapai setelah pertemuan ketujuh, di mana sebagian besar responden melaporkan bahwa nyeri punggung mereka turun ke tingkat yang ringan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang terintegrasi, yang menggabungkan manfaat fisik dari yoga dan manfaat psikologis dari hipnoterapi, mampu membantu ibu hamil mengelola nyeri punggung dengan lebih efektif (Nur Arummega et al., 2022; Ramadhan et al., 2024).

Dengan demikian, prenatal yoga yang dikombinasikan dengan hipnoterapi tidak hanya memberikan dukungan fisik dalam meredakan nyeri punggung pada ibu hamil, tetapi juga berperan penting dalam membangun ketahanan mental. Prenatal yoga membantu melatih otot-otot punggung dan panggul sehingga lebih fleksibel, sekaligus memperbaiki postur tubuh ibu hamil yang berubah akibat pertumbuhan janin. Sementara itu, hipnoterapi memberikan efek relaksasi yang mendalam, membantu ibu hamil mengelola stres dan mengurangi persepsi nyeri melalui pengelolaan sinyal rasa sakit di otak.

Kombinasi kedua metode ini menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pengurangan nyeri secara fisiologis, tetapi juga mendukung kesehatan psikologis ibu hamil. Penurunan nyeri punggung yang

signifikan, seperti terlihat pada penelitian ini, mulai terjadi sejak sesi keempat dan semakin membaik pada pertemuan ketujuh, menunjukkan bahwa latihan teratur dapat memberikan hasil yang optimal (Nur Arummega et al., 2022; Ramadhan et al., 2024).

Selain memberikan kenyamanan selama masa kehamilan, prenatal yoga dan hipnoterapi membantu ibu hamil merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi proses persalinan. Pendekatan ini memastikan ibu hamil memiliki pengalaman kehamilan yang lebih positif, dengan kualitas hidup yang meningkat karena bebas dari ketidaknyamanan kronis, seperti nyeri punggung, yang sering kali menjadi keluhan utama selama kehamilan (Dewi Rosita et al., 2022; Adnyani, 2021). Oleh karena itu, penerapan kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi secara rutin sangat direkomendasikan bagi ibu hamil, tidak hanya sebagai solusi pengelolaan nyeri, tetapi juga sebagai cara untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental menghadapi momen penting dalam kehidupan mereka.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini telah berhasil mengeksplorasi efektivitas kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi sebagai metode integrasi dalam mengatasi nyeri punggung bawah yang sering dialami oleh ibu hamil, khususnya pada trimester kedua dan ketiga. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pendekatan ini terbukti memberikan manfaat signifikan, baik secara fisiologis maupun psikologis, terhadap pengurangan intensitas nyeri punggung yang dialami oleh responden.

Prenatal yoga, sebagai bentuk olahraga yang dirancang khusus untuk ibu hamil, berkontribusi pada peningkatan fleksibilitas otot, perbaikan postur tubuh, serta relaksasi yang mendalam. Latihan ini membantu ibu hamil dalam menghadapi perubahan biomekanis tubuh akibat pertumbuhan janin, seperti redistribusi berat badan dan peningkatan tekanan pada tulang belakang. Gerakan yang dilakukan secara teratur dengan intensitas yang sesuai dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh, mengurangi ketegangan pada otot punggung, serta meningkatkan sirkulasi darah.

Sementara itu, hipnoterapi sebagai metode non-farmakologis turut mendukung pengelolaan nyeri dari sisi psikologis. Dengan menanamkan sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar, hipnoterapi membantu ibu hamil mengelola stres dan mengurangi persepsi nyeri. Mekanisme ini melibatkan stimulasi sistem limbik, pelepasan

neurotransmitter seperti endorfin dan GABA, serta peningkatan aktivitas dopaminergik di otak, yang secara signifikan menurunkan intensitas nyeri punggung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi yang dilakukan secara teratur dua kali seminggu selama empat minggu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan skala nyeri punggung pada ibu hamil. Berdasarkan analisis statistik, nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,00$ dan $p = 0,01$ dengan korelasi $r = 0,702$ mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara intervensi ini dengan pengurangan nyeri. Penurunan tingkat nyeri mulai terlihat sejak sesi keempat dan mencapai hasil optimal pada sesi ketujuh, di mana sebagian besar responden melaporkan nyeri yang berkurang menjadi kategori ringan.

Selain manfaat dalam pengelolaan nyeri, pendekatan ini juga mendukung peningkatan kualitas hidup ibu hamil secara keseluruhan. Prenatal yoga memberikan kesempatan bagi ibu untuk membangun ikatan emosional dengan janin, sementara hipnoterapi membantu menciptakan kondisi mental yang lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Kombinasi ini memastikan ibu hamil memiliki pengalaman kehamilan yang lebih positif dan nyaman.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan intervensi serupa di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan prenatal yoga dan hipnoterapi di kelas ibu hamil, baik di rumah sakit maupun komunitas, dapat menjadi alternatif non-farmakologis yang efektif untuk mengatasi keluhan nyeri punggung selama kehamilan. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang

untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas metode ini pada berbagai populasi ibu hamil, termasuk mereka yang memiliki riwayat nyeri kronis atau kondisi kesehatan lainnya.

B. Implikasi Praktis

Temuan dari studi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan strategi intervensi non-farmakologis untuk mengelola nyeri punggung pada ibu hamil. Prenatal yoga dan hipnoterapi, sebagai pendekatan yang terbukti efektif, dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan kehamilan yang komprehensif, khususnya yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, atau instruktur yoga prenatal bersertifikasi. Metode ini juga dapat menjadi salah satu layanan unggulan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kebugaran khusus ibu hamil. Dengan penerapan ini, ibu hamil tidak hanya mendapat solusi praktis untuk mengatasi nyeri punggung, tetapi juga memperoleh manfaat tambahan berupa peningkatan kualitas hidup selama masa kehamilan.

Integrasi prenatal yoga dan hipnoterapi di fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui penyediaan kelas-kelas khusus yang dirancang sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi fisik ibu. Misalnya, rumah sakit atau klinik dapat menjadwalkan sesi prenatal yoga secara berkala, dipandu oleh instruktur profesional yang memahami kebutuhan ibu hamil. Selain itu, hipnoterapi dapat ditawarkan sebagai bagian dari terapi relaksasi untuk membantu ibu hamil mengelola nyeri, kecemasan, dan stres yang sering terjadi selama kehamilan. Program ini tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan yang ditawarkan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan antara penyedia layanan kesehatan

dengan pasien, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan mendukung.

Untuk mendukung keberlanjutan manfaat dari metode ini, pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan dan penyedia layanan kehamilan menjadi hal yang sangat penting. Bidan, dokter, atau instruktur yoga perlu dilatih agar mampu mengajarkan teknik prenatal yoga dan hipnoterapi secara efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan individual ibu hamil. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang kontraindikasi, penyesuaian gerakan, dan cara memberikan instruksi yang ramah kepada peserta, sehingga ibu hamil dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam mempraktikkan teknik ini.

Lebih lanjut, pelatihan ini memungkinkan para penyedia layanan untuk memberikan panduan kepada ibu hamil tentang bagaimana melanjutkan praktik prenatal yoga dan hipnoterapi di rumah secara mandiri. Dengan kemampuan ini, ibu hamil dapat menjadikan aktivitas ini sebagai bagian dari rutinitas harian mereka, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan selama sesi formal, tetapi juga secara berkelanjutan dalam mendukung kesehatan fisik dan mental. Dalam jangka panjang, langkah ini berkontribusi pada upaya pencegahan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti nyeri kronis atau gangguan kecemasan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi.

Pentingnya dukungan dari komunitas kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, fasilitas kebugaran, dan penyedia pelatihan dapat memperluas jangkauan metode ini kepada lebih banyak ibu hamil, termasuk mereka yang berada di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Dengan pengembangan model pelatihan yang fleksibel, seperti penggunaan modul daring

atau sesi pelatihan kelompok, manfaat dari prenatal yoga dan hipnoterapi dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Dengan mengadopsi pendekatan holistik ini, fasilitas kesehatan tidak hanya berperan dalam pengelolaan nyeri punggung pada ibu hamil tetapi juga mendukung kesehatan ibu secara keseluruhan. Integrasi prenatal yoga dan hipnoterapi dalam sistem pelayanan kesehatan membuka peluang besar untuk memberikan solusi inovatif yang aman, praktis, dan berkelanjutan dalam meningkatkan pengalaman kehamilan yang lebih sehat dan bermakna.

C. Rekomendasi

Hasil temuan ini memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan wawasan lebih lanjut terkait efektivitas kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi dalam mengatasi nyeri punggung pada ibu hamil. Beberapa rekomendasi berikut diharapkan dapat membantu memperluas aplikasi dan pemahaman terhadap metode ini di berbagai konteks kesehatan.

1. Memperluas Ruang Lingkup Kajian

Untuk mendapatkan hasil yang lebih inklusif dan relevan, diperlukan perluasan cakupan kajian yang melibatkan lebih banyak ibu hamil dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam variasi efektivitas metode prenatal yoga dan hipnoterapi dalam kondisi yang beragam. Responden dari daerah perkotaan, pedesaan, maupun wilayah terpencil mungkin memiliki pengalaman yang berbeda terkait akses layanan kesehatan, sehingga memungkinkan penyesuaian metode ini untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Dengan melibatkan populasi yang lebih luas, diharapkan dapat

diperoleh hasil yang mencerminkan kebutuhan ibu hamil secara lebih menyeluruh.

2. Pemantauan jangka panjang

Dampak jangka panjang dari metode prenatal yoga dan hipnoterapi juga perlu menjadi perhatian penting. Pemantauan dapat dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kedua metode ini memengaruhi ibu hamil tidak hanya selama kehamilan, tetapi juga selama periode setelah melahirkan (postpartum). Kajian lebih lanjut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kombinasi ini membantu mencegah nyeri punggung yang berkepanjangan, mendukung pemulihan pasca-persalinan, dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta emosional ibu baru.

3. Pengembangan panduan praktis

Salah satu langkah strategis untuk memperluas penerapan metode ini adalah dengan menyusun panduan praktis yang komprehensif terkait pelaksanaan prenatal yoga dan hipnoterapi. Panduan ini dirancang agar mudah dipahami oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, atau instruktur yoga prenatal, serta dapat digunakan oleh ibu hamil secara mandiri. Konten panduan dapat berupa instruksi langkah-langkah gerakan, penyesuaian untuk kondisi tertentu, hingga kontraindikasi yang harus dihindari. Dalam pelaksanaannya, panduan ini juga dapat dilengkapi dengan media pendukung, seperti video, ilustrasi, dan modul pembelajaran yang terstruktur, sehingga metode ini dapat diimplementasikan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kebugaran ibu hamil.

4. Pemanfaatan teknologi digital

Seiring dengan perkembangan teknologi, platform digital dapat menjadi sarana yang inovatif untuk menyediakan akses kepada ibu hamil yang ingin mempraktikkan prenatal yoga dan hipnoterapi. Pengembangan aplikasi seluler atau platform daring yang dirancang khusus untuk ibu hamil dapat menjadi solusi yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Aplikasi ini dapat mencakup fitur-fitur seperti video tutorial, panduan langkah-langkah latihan, pengingat jadwal, serta ruang komunitas virtual untuk berbagi pengalaman. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya memperluas jangkauan manfaat metode ini, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi ibu hamil untuk melakukan latihan kapan saja dan di mana saja.

Prenatal yoga dan hipnoterapi merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya aman tetapi juga efektif dalam mendukung ibu hamil mengelola nyeri punggung. Kombinasi keduanya memberikan manfaat yang menyeluruh, mulai dari aspek fisiologis dengan memperbaiki postur dan fleksibilitas otot, hingga aspek psikologis dengan meningkatkan relaksasi, mengurangi stres, dan membantu pengelolaan emosi. Pendekatan ini menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih nyaman, menyenangkan, dan penuh percaya diri bagi ibu hamil.

Hasil dari kajian ini juga membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung layanan kesehatan ibu hamil. Dengan kombinasi metode ini, ibu hamil tidak hanya memperoleh solusi praktis dalam mengatasi nyeri punggung, tetapi juga didorong untuk menjalani kehamilan dengan kualitas hidup yang

lebih baik. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, penyedia layanan, dan ibu hamil itu sendiri dalam menerapkan metode ini secara aman dan efektif.

Melalui pengembangan metode ini secara luas, baik dalam lingkup masyarakat maupun fasilitas kesehatan, diharapkan kombinasi prenatal yoga dan hipnoterapi dapat menjadi salah satu pendekatan utama dalam perawatan kehamilan yang lebih holistik. Dengan langkah ini, ibu hamil dari berbagai latar belakang dan kondisi dapat merasakan manfaat yang signifikan, sehingga menciptakan kehamilan yang lebih sehat, nyaman, dan bermakna

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtya, P., & Prasetyorini, H. (2024). Penerapan Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 8(1), 41–46. <https://doi.org/10.33655/mak.v8i1.186>
- Aprilyadi, N., Zuraidah, Z., & Ridawati, I. D. (2020). Pelatihan Hipnoterapi Untuk Menurunkan Nyeri Dismenorea pada Siswi SMA PGRI I Kota Lubuklinggau. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 217–224. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.67>
- Asyima, A., & Wulandari, I. A. (2021). Penggunaan hipnoterapi untuk menurunkan nyeri pada ibu post seksio sesarea. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 15(1), 110–116. <https://doi.org/10.33024/hjk.v15i1.4176>
- Fazriani, N., & Marwasariaty. (2024). EFEKTIVITAS PRENATAL YOGA TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Kesehatan Arunika*, 1(1). <https://jurnal.lppmstikeskami.ac.id/index.php/kesehatanarunika/index>
- Halim, A. R., & Khayati, N. (2020). Pengaruh Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks. *Ners Muda*, 1(3), 159. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i3.6211>
- Ma'rifah, U., Rozifa, A. W., & Tadzkiroh, U. (2021). Hipnoterapi Untuk Mengurangi Nyeri Kala I. *Jurnal Keperawatan Muhamadiyah*, 6(2).

- Nurmitasari. (2022). Efek Hipnoterapi Pada Perkembangan Persalinan. Media Publikasi Penelitian Kebidanan, 5(2).
- Pramesti, I., Poerwantoro, B., & Arifandi, F. (2023). HIPNOTERAPI DALAM PRAKTIK DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN TINJAUANNYA MENURUT ISLAM. Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(1).
- Wulandari, D. A., Ahadiyah, E., & Ulya, F. H. (2020). Prenatal Yoga untuk Mengurangi Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III. Jurnal SMART Kebidanan, 7(1), 9. <https://doi.org/10.34310/sjkb.v7i1.349>

GLOSARIUM

B

Bonding : Ikatan emosional antara ibu hamil dengan janinnya, sering diperkuat melalui kegiatan seperti prenatal yoga.

E

Emboli : Gangguan pada aliran darah yang dapat terjadi jika tubuh dalam posisi terbalik terlalu lama.

H

Hipnoterapi : Metode pengobatan yang menggunakan hipnosis, yaitu teknik untuk memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti.

Hormon Relaksin: Hormon yang diproduksi selama kehamilan untuk melonggarkan persendian dan mempersiapkan tubuh ibu untuk persalinan.

HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir): Metode untuk menghitung usia kehamilan, dimulai dari hari pertama menstruasi terakhir.

K

Kehamilan : Periode mulai dari konsepsi hingga lahirnya janin, berlangsung sekitar 280 hari atau 40

minggu dihitung dari Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT).

Kifosis : Lengkungan kompensasi pada tulang belakang torakal, biasanya terjadi akibat adaptasi postur tubuh selama kehamilan.

Komplikasi Kehamilan: Kondisi medis yang berpotensi membahayakan ibu hamil dan janin, seperti hipertensi, diabetes gestasional, atau perdarahan.

L

Lordosis : Peningkatan lengkungan pada bagian lumbar tulang belakang, sering terjadi pada ibu hamil karena perubahan postur tubuh.

M

Masase : Teknik pemijatan untuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah.

Meditasi : Latihan mental untuk meningkatkan konsentrasi, relaksasi, dan pengendalian emosi. Bagian penting dari prenatal yoga.

N

NSAID : (*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs*)
Obat anti-inflamasi non-steroid yang dilarang digunakan pada trimester ketiga kehamilan karena dapat memengaruhi perkembangan janin.

Nyeri Punggung Bawah: Kondisi ketidaknyamanan yang sering dialami ibu hamil akibat perubahan fisiologis

seperti pergeseran pusat gravitasi dan penambahan berat badan.

Nyeri : Sebuah pengalaman sensorik dan emosional negatif yang muncul akibat kerusakan jaringan, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tubuh.

P

Postur Kobra (Bhujaungasana): Gerakan yoga yang menekan perut, tidak disarankan untuk ibu hamil.

Prenatal Yoga: Modifikasi gerakan yoga yang disesuaikan untuk ibu hamil, bertujuan untuk melenturkan persendian, relaksasi, dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta psikologis.

Pusat Gravitasi: Titik keseimbangan tubuh yang bergeser ke depan selama kehamilan akibat pembesaran rahim.

R

Relaksasi Mendalam: Teknik relaksasi tingkat lanjut yang melibatkan meditasi dan fokus pernapasan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran.

S

Senam Hamil : Olahraga ringan khusus untuk ibu hamil yang bertujuan untuk menjaga kebugaran, melatih pernapasan, dan mempersiapkan tubuh untuk melahirkan.

Senam Prenatal: Latihan fisik khusus untuk ibu hamil, mencakup gerakan-gerakan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan fisik serta mental.

Senam Yoga : Latihan fisik, mental, dan spiritual yang membantu melenturkan tubuh, memperbaiki postur, dan meningkatkan ketenangan.

Skala Nyeri Numerik: Alat ukur untuk menilai tingkat nyeri berdasarkan angka, biasanya dari 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri sangat berat).

T

Trimester Kehamilan: Pembagian usia kehamilan menjadi tiga periode

V

Vena Cava Inferior: Pembuluh darah besar yang mengembalikan darah kotor dari tubuh bagian bawah ke jantung. Tekanan pada vena ini saat berbaring telentang dapat mengurangi aliran darah.

PROFIL PENULIS



Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes., lahir di Jombang Jawa Timur, 15 Maret 1963. Lulus Akper Soetomo Surabaya tahun 1992. Tahun 1994 lulus program Bidan di Akper Sutopo Surabaya, lulus dari PSIK UNPAD Bandung tahun 2000, menyelesaikan Magister KIA Kespro di UGM Yogyakarta tahun 2007. Terakhir mengikuti Pendidikan Doktorat Kesehatan di UNAIR tahun 2016. Penulis tinggal di Kabupaten Jombang Prov. Jatim. Karir penulis diawali mulai sebagai ASN di DinKes Kabupaten

Jombang dan ditempatkan di Puskesmas tahun 1984 sampai 1994, selanjutnya pindah ke SPK Pemkab Jombang sampai tahun 2006. Tahun 2016 pindah ke Departemen Riset dan Teknologi dan ditempatkan di Stikes Pemkab Jombang dengan tugas tambahan sebagai Kaprodi Sarjana Keperawatan, tahun 2016 sebagai Waket 1 Bidang Akademik sampai tahun 2023, saat ini sebagai dosen Prodi S 1 Keperawatan Stikes Pemkab Jombang dengan jabatan fungsional Lektor. Penulis memberikan kuliah Maternitas, manajemen dan Metodologi, serta membimbing mahasiswa profesi ners. Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis tersertifikasi dosen dan aktif sebagai fasilitator kegiatan Percepthorship yang dilakukan oleh Kemenkes melalui Badan Diklat DPW PPNI Provinsi Jawa timur. Penulis juga aktif di DPW PPNI Provinsi Jawa Timursaat ini sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan periode 2022-2026, sekaligus sebagai wakil Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI). Sebagai Ketua Dewas di RSKM Jombang, selain itu juga aktif di Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai sekretaris untuk wilayah Mojokerto-Jombang. *Email:* sestu.retno@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Rodiyah, S.Kep.Ns,M.Kes. Lahir di Tulungagung, 26 April 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999 sebagai perawat pelaksana pada BKIA Aisyiyah Bandung Tulungagung. Tahun 2008 s/d sekarang penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang mengampu mata kuliah keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: azizdanahsan@gmail.com

Motto: Jadilah wanita yang sukses dunia akhirat

PROFIL PENULIS



Dewi Ratih Purnomo, S.Kep lahir di Jombang pada tanggal 20 Agustus 2001. Penulis telah menempuh pendidikan tinggi jenjang Sarjana Keperawatan di STIKES Pemkab Jombang. Penulis telah aktif melakukan penulisan karya ilmiah sejak mengenyam pendidikan tinggi. Karir penulis diawali sejak memasuki dunia perkuliahan, berawal dari freelance entry data, kemudian beralih menjadi

design grafis di Bukajobs media sejak Januari 2021 sampai September 2024, menjadi redaktur pelaksana di Terasharian.com pada Juni-September 2024, kemudian fokus aktif dalam bidang karya ilmiah sejak akhir 2023 dan telah berhasil melakukan publikasi HAKI "Serenatal Method" dari hasil penelitian pada 4 Desember 2024 dan sedang proses menunggu proses publikasi jurnal Sinta 4 selesai. Penulis juga berkarir sebagai personal asisten Wakil Ketua II STIKES Pemkab Jombang sejak Oktober 2024. Selain itu, penulis juga aktif membimbing dan mengarahkan mahasiswa diploma, sarjana dan doktoral yang mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiahnya.

Motto: Hidup tanpa takut, mati tanpa sesal

SINOPSIS BUKU

Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologis yang dapat menyebabkan nyeri punggung khususnya pada usia kehamilan Trimester III, hal ini sangat berdampak terhadap kualitas hidup dan aktivitas ibu hamil.

Banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk penanganan nyeri punggung pada kehamilan baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Namun pengobatan secara farmakologis dilaporkan memiliki banyak dampak tidak baik bagi kehamilan, oleh sebab itu metode non-farmakologis yang ditemukan lebih efektif. Salah satu metode yang disarankan adalah kombinasi senam Prenatal yoga dan Hipnoterapi.

Senam Prenatal yoga dan hipnoterapi yang dilakukan secara benar dan teratur seminggu 2x selama 4 minggu berturut-turut terbukti dapat secara signifikan menurunkan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III.

Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologis yang dapat menyebabkan nyeri punggung khususnya pada usia kehamilan Trimester III, hal ini sangat berdampak terhadap kualitas hidup dan aktivitas ibu hamil.

Banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk penanganan nyeri punggung pada kehamilan baik secara farmakologis maupun non farmakologis. Namun pengobatan secara farmakologis dilaporkan memiliki banyak dampak tidak baik bagi kehamilan, oleh sebab itu metode non-farmakologis yang ditemukan lebih efektif.

Salah satu metode yang disarankan adalah kombinasi senam Prenatal yoga dan Hipnoterapi.

Senam Prenatal yoga dan hipnoterapi yang dilakukan secara benar dan teratur seminggu 2x selama 4 minggu berturut-turut terbukti dapat secara signifikan menurunkan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kéc. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

